Estilo UERJ

Simulado R02 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	15	1, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 27, 28, 30, 32, 39, 45, 46, 49
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	4	11, 14, 15, 40
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	4	6, 8, 24, 48
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	3	22, 38, 47
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	8	2, 4, 12, 16, 26, 34, 36, 50
Qualificador	o comando restringe o que se pede	1	35
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	7	3, 18, 21, 23, 29, 33, 41
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	4	5, 20, 43, 44
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	4	25, 31, 37, 42

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante nos Simulados 1 a 4.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **D**	2 **D**	3 **D**	4 **D**	5 **C**	6 **C**	7 **C**	8 **C**	9 **B**	10 **B**
11 **B**	12 **C**	13 **B**	14 **C**	15 **A**	16 **A**	17 **C**	18 **B**	19 **A**	20 **C**
21 **C**	22 **D**	23 **A**	24 **C**	25 **A**	26 **A**	27 **A**	28 **C**	29 **B**	30 **D**
31 **A**	32 **B**	33 **A**	34 **B**	35 **A**	36 **D**	37 **D**	38 **A**	39 **D**	40 **D**
41 **B**	42 **B**	43 **B**	44 **D**	45 **D**	46 **A**	47 **D**	48 **B**	49 **C**	50 **A**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 12, C 12, D 13.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Infectologia · Endocardite de prótese mecânica nos primeiros meses após colonoscopia: empírico antiestafilocócico de prótese, e não o do enterococo

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Mulher de 58 anos, com prótese mecânica mitral implantada há 5 meses, em uso de varfarina, fez colonoscopia com polipectomia há 3 semanas e há 10 dias tem febre de 38,4 °C diária, sudorese noturna e astenia. Ao exame, PA 118 × 70 mmHg, FC 98 bpm, clique metálico nítido, sopro sistólico novo em foco mitral grau 2+/6+, sem sinais de insuficiência cardíaca. Ferida operatória cicatrizada. Ecocardiograma transesofágico: vegetação de 8 mm no anel protético com pequeno leak paravalvar, sem abscesso. Três pares de hemoculturas foram colhidos há 1 hora, ainda sem resultado. INR 2,8, creatinina 0,9 mg/dL. Enquanto aguarda as culturas, o esquema empírico mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

prótese mecânica mitral implantada há 5 meses

Resolução. A polipectomia recente é verdadeira e puxa para enterococo, cujo esquema seria ampicilina com ceftriaxona. Mas a endocardite em prótese implantada há menos de 12 meses é tratada como infecção relacionada ao procedimento cardíaco, e o agente que domina essa janela é o estafilococo (coagulase-negativo, frequentemente resistente à oxacilina, e Staphylococcus aureus). Por isso o empírico de prótese precoce cobre estafilococo resistente com vancomicina, acrescenta gentamicina e inclui rifampicina pela ação sobre o biofilme do material protético, que deve entrar alguns dias depois das outras drogas. Quando as culturas voltarem, o esquema é ajustado ao agente, e se for enterococo a troca é imediata. Oxacilina não cobre o coagulase-negativo resistente, que é o mais comum nessa fase.

A) Ampicilina com ceftriaxona ARMADILHA
Errada. É a armadilha da colonoscopia: seria o esquema dirigido para Enterococcus faecalis, depois de identificado, e não o empírico de prótese recente.

B) Penicilina cristalina com gentamicina
Errada. Esquema dirigido para estreptococo sensível em valva nativa; não cobre estafilococo, que domina o primeiro ano após a cirurgia.

C) Oxacilina com gentamicina
Errada. Cobre apenas estafilococo sensível à oxacilina e deixa sem cobertura o coagulase-negativo resistente, o mais frequente na prótese precoce.

D) Vancomicina, gentamicina e rifampicina CORRETA
Correta. Prótese com menos de 12 meses: cobertura de estafilococo resistente e biofilme, com vancomicina, gentamicina e rifampicina.

Para levar. Na endocardite de prótese, o tempo desde a cirurgia vale mais que o procedimento recente: com menos de 12 meses, o empírico é vancomicina, gentamicina e rifampicina.

2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis; AHA Scientific Statement on Infective Endocarditis in Adults (Baddour et al., 2015).

Revisa: S2 q1: o tempo desde o implante da prótese define o agente e o empírico, e não o procedimento invasivo recente

---

2

Hematologia · Linfoma folicular com linfonodos pequenos e derrame pleural: alta carga tumoral pelo GELF, imunoquimioterapia

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 58 anos, assintomática, sem febre, sudorese ou perda de peso, notou linfonodos cervicais e axilares há 8 meses. TC: linfonodomegalias cervicais, axilares, mediastinais e retroperitoneais, todas abaixo de 3 cm (a maior com 2,9 cm), baço de 12 cm e derrame pleural direito moderado, cuja citologia mostra linfócitos B pequenos clonais. Hemoglobina 12,8 g/dL, leucócitos 6.900/mm³, plaquetas 188.000/mm³, LDH 210 U/L (até 250). Biópsia excisional axilar: padrão nodular, CD20+, CD10+, BCL2+, BCL6+, CD5 negativo, ciclina D1 negativa, grau 1 a 2. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

derrame pleural direito moderado

Resolução. O imunofenótipo (CD10+, BCL2+, BCL6+, CD5 e ciclina D1 negativos) e o padrão nodular definem linfoma folicular, e paciente assintomática com linfonodos todos abaixo de 3 cm e LDH normal parece candidata à observação vigilante. Os critérios do GELF, porém, não se limitam ao tamanho dos linfonodos: qualquer um deles (três ou mais sítios acima de 3 cm, massa acima de 7 cm, sintomas B, esplenomegalia sintomática, compressão de órgão, derrame seroso, citopenias, leucemização ou LDH alta) indica alta carga tumoral. O derrame pleural com células clonais basta. Com alta carga, a indicação é tratar com anti-CD20 associado a quimioterapia (bendamustina ou CHOP), seguido de manutenção conforme a resposta.

A) Linfoma do manto / ibrutinibe
Errada. O manto é CD5+ e ciclina D1+; aqui ambos são negativos.

B) Linfoma folicular / observação vigilante ARMADILHA
Errada. É a armadilha do tamanho: os linfonodos são pequenos, mas derrame pleural é critério GELF de alta carga.

C) Linfoma de zona marginal / rituximabe isolado
Errada. A zona marginal é CD10 negativo; o CD10 e o BCL6 positivos apontam para o centro germinativo.

D) Linfoma folicular / imunoquimioterapia com anti-CD20 CORRETA
Correta. Folicular pelo imunofenótipo, com alta carga pelo derrame seroso: imunoquimioterapia com anti-CD20.

Para levar. No linfoma folicular, um único critério GELF (inclusive derrame seroso ou citopenia) tira o paciente da observação vigilante, mesmo com linfonodos pequenos.

ESMO Clinical Practice Guidelines for newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma (2021); NCCN B-Cell Lymphomas (2026).

Revisa: S2 q5: carga tumoral do folicular, agora o critério GELF fora do tamanho dos linfonodos invertendo a conduta

---

3

Reumatologia · Monoartrite com cristais de pirofosfato em idoso com flebite de cateter e 62.000 leucócitos no líquido: drenagem e antibiótico venoso

Limiar **Gabarito D**

Homem de 79 anos, com condrocalcinose dos joelhos documentada há 5 anos e duas crises prévias de pseudogota, está internado há 9 dias por pneumonia, já em melhora. Há 4 dias surgiu flebite no local do cateter venoso periférico, retirado; hoje tem febre de 38,4 °C e joelho direito quente, edemaciado e doloroso, com derrame volumoso. Artrocentese: líquido turvo, 62.000 leucócitos/mm³ com 91% de neutrófilos, cristais romboides com birrefringência positiva fraca, bacterioscopia pelo Gram sem bactérias. Radiografia: condrocalcinose sem erosões. Hemoculturas colhidas, em processamento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

62.000 leucócitos/mm³ com 91% de neutrófilos

Resolução. Condrocalcinose conhecida, crises prévias e cristais de pirofosfato no líquido levam a tratar como nova crise de pseudogota, e a infiltração com corticoide parece a medida mais eficaz. Achar cristais não exclui infecção, que pode coexistir e até desencadear a crise. A celularidade acima de 50.000 leucócitos com predomínio neutrofílico acima de 90%, a febre e a porta de entrada recente (flebite de cateter, com risco de bacteremia por S. aureus) obrigam a tratar como artrite séptica até as culturas voltarem. O Gram negativo tem baixa sensibilidade e não afasta infecção. A conduta é drenagem articular (por punções repetidas ou artroscopia) e antibiótico venoso com cobertura para estafilococo, ajustado pela cultura. Corticoide intra-articular numa articulação possivelmente infectada é contraindicado.

A) Colchicina oral em dose baixa
Errada. Colchicina trataria a pseudogota isolada; não cobre a infecção, que a celularidade e a porta de entrada tornam provável.

B) Triancinolona intra-articular ARMADILHA
Errada. É a armadilha dos cristais: a infiltração é o tratamento da crise de pseudogota sem infecção, e é contraindicada com suspeita de artrite séptica.

C) Prednisona oral 30 mg/dia
Errada. Corticoide sistêmico serve à crise poliarticular sem infecção; aqui atrasaria o tratamento da artrite séptica.

D) Drenagem e antibiótico venoso CORRETA
Correta. Mais de 50.000 leucócitos com neutrofilia acima de 90%, febre e bacteremia possível: tratar como séptica até prova em contrário.

Para levar. Cristais no líquido sinovial não afastam infecção: celularidade acima de 50.000 com neutrófilos acima de 90%, febre ou porta de entrada mandam drenar e iniciar antibiótico até a cultura.

Ravindran V et al. BSR and BHPR guideline for the management of the hot swollen joint in adults (2017); Rosenthal AK, Ryan LM. Calcium Pyrophosphate Deposition Disease. N Engl J Med 2016.

Revisa: S2 q21: artrite séptica sobre artropatia por cristais; agora pirofosfato e bacteremia de cateter em vez de gota

---

4

Endocrinologia · Estado hiperosmolar hiperglicêmico após a reposição inicial, com sódio corrigido acima de 160: solução salina a 0,45% e insulina contínua

Grade X / Y

Gabarito D

Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 e demência leve, chega com 5 dias de poliúria, sede e confusão progressiva. Na admissão, PA 88 × 50 mmHg e FC 122 bpm; recebeu 2.000 mL de solução salina a 0,9% em 2 horas. Agora, PA 126 × 74 mmHg, FC 96 bpm, diurese de 60 mL/h, sem sinais de congestão. Glicemia 880 mg/dL, sódio medido de 148 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, osmolalidade efetiva 345 mOsm/kg, pH 7,34, bicarbonato 21 mEq/L, cetonemia negativa, creatinina 2,0 mg/dL. A solução venosa e a insulina mais adequadas neste momento são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

sódio medido de 148 mEq/L

Resolução. Quem fixou que no estado hiperosmolar o volume isotônico vem antes de tudo tende a manter a salina a 0,9%. Essa regra vale para a fase de choque, já resolvida: a pressão normalizou e a diurese voltou. Na fase seguinte, a escolha do fluido depende do sódio corrigido para a glicemia, que aqui é de cerca de 160 a 166 mEq/L (148 mais 1,6 a 2,4 para cada 100 mg/dL acima de 100), indicando grande déficit de água livre. Com o paciente estável e o sódio corrigido alto, troca-se para salina a 0,45%. O potássio de 4,4 mEq/L permite iniciar a insulina contínua em dose baixa, com reposição de potássio no soro; quando a glicemia chegar perto de 300 mg/dL, acrescenta-se glicose. A queda da osmolalidade deve ser gradual, para evitar edema cerebral.

A) Salina a 0,9% / insulina contínua ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a salina a 0,9% é o fluido da fase de hipotensão; estável e com sódio corrigido alto, ela mantém a hipernatremia.

B) Salina a 0,9% / insulina só abaixo de 300
Errada. Repete o erro do fluido e ainda adia a insulina sem motivo, com potássio adequado.

C) Glicosado a 5% / insulina contínua
Errada. Glicose entra quando a glicemia se aproxima de 300 mg/dL, e não com 880 mg/dL.

D) Salina a 0,45% / insulina contínua CORRETA
Correta. Estabilizado e com sódio corrigido acima de 160, salina a 0,45% com insulina contínua em dose baixa.

Para levar. Estado hiperosmolar: salina a 0,9% enquanto houver instabilidade; depois, sódio corrigido normal ou alto pede salina a 0,45%, e baixo mantém a 0,9%. Insulina com potássio acima de 3,3.

Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care 2024; Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2024).

Revisa: S3 q68: fluido no estado hiperosmolar; agora a fase seguinte, em que o sódio corrigido troca a solução

---

5

Gastroenterologia e hepatologia · Encefalopatia hepática recorrente com função hepática preservada apesar de lactulose e rifaximina: procurar shunt portossistêmico espontâneo

Omissão **Gabarito C**

Homem de 61 anos, com cirrose por hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 3 anos, é internado pelo terceiro episódio de encefalopatia hepática grau 2 em 8 meses. Usa lactulose com 2 a 3 evacuações pastosas ao dia, confirmadas pela esposa, e rifaximina há 5 meses. Em todas as internações não se achou infecção, sangramento, distúrbio eletrolítico, uso de sedativo, constipação ou hipoglicemia. Child-Pugh A6, MELD 9, sem ascite. Ultrassonografia com Doppler: fígado de contornos irregulares, baço de 15 cm, veia porta pérvia de calibre reduzido. TSH e B12 normais. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Child-Pugh A6, MELD 9, sem ascite

Resolução. Encefalopatia que volta apesar de lactulose bem tomada e rifaximina costuma levar a dosar amônia ou a procurar outra causa no sistema nervoso central. O dado que destoa é a função hepática quase normal: encefalopatia recorrente sem fator precipitante num Child A com MELD 9 sugere que o sangue portal chega à circulação sistêmica por um desvio, e não por falência hepatocelular. A veia porta de calibre reduzido com baço grande reforça a hipótese de shunt portossistêmico espontâneo calibroso (esplenorrenal, gastrorrenal, umbilical). A angiotomografia do abdome identifica o shunt, e a embolização dele em paciente com função hepática preservada reduz as recorrências.

A) Ressonância de crânio com espectroscopia
Errada. Ressonância de crânio entra quando o quadro neurológico não é compatível com encefalopatia hepática; aqui os episódios responderam ao tratamento.

B) Eletroencefalograma
Errada. O eletroencefalograma ajuda a graduar ou excluir estado de mal não convulsivo, mas não explica a recorrência.

C) Angiotomografia do abdome CORRETA
Correta. Recorrência sem precipitante com Child A e MELD baixo: pesquisar shunt portossistêmico espontâneo para embolização.

D) Amônia sérica arterial ARMADILHA
Errada. A amônia não muda a conduta numa encefalopatia já caracterizada e não aponta a causa da recorrência.

Para levar. Encefalopatia hepática recorrente apesar de lactulose e rifaximina, com função hepática preservada, é shunt portossistêmico espontâneo até prova em contrário: angiotomografia e embolização.

EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy (2022); AASLD/EASL Practice Guideline Hepatic Encephalopathy (2014).

Revisa: S4 q69: escalonamento na encefalopatia recorrente, agora o passo depois da rifaximina

---

6 Neurologia · Vertigem, disfagia, rouquidão e Horner após manipulação cervical: síndrome bulbar lateral e a hipoalgesia alterna

Dado omitido **Gabarito C**

Homem de 46 anos fez manipulação cervical com quiroprático há 2 dias e desde então tem dor na nuca à direita. Há 6 horas teve vertigem súbita, vômitos, rouquidão, dificuldade para engolir a própria saliva e soluços incessantes. Exame: alerta, PA 152 × 90 mmHg; ptose e miose à direita, nistagmo horizontal, palato que se eleva menos à direita com reflexo nauseoso diminuído desse lado, ataxia dos membros à direita, força preservada nos quatro membros, língua na linha média e reflexos simétricos, sem sinal de Babinski. Ainda não foi testada a sensibilidade. O achado sensitivo mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

ptose e miose à direita

Resolução. Vertigem, disfagia, rouquidão e soluços com Horner, paresia do palato e ataxia de membros do mesmo lado, sem fraqueza, localizam o bulbo lateral direito (síndrome de Wallenberg), aqui por dissecção da artéria vertebral após manipulação cervical. No bulbo lateral passam, lado a lado, o trato e o núcleo espinhal do trigêmeo, que carregam dor e temperatura da face do mesmo lado (ainda não cruzadas), e o trato espinotalâmico, que carrega dor e temperatura do corpo do lado oposto (já cruzado na medula). Daí a hipoalgesia alterna: face direita e hemicorpo esquerdo. A perda proprioceptiva contralateral é do lemnisco medial, que está no bulbo medial, junto com o trato piramidal e o hipoglosso; força preservada, língua na linha média e ausência de Babinski afastam lesão medial.

A) Hipoalgesia na hemiface e no hemicorpo direitos
Errada. Hipoalgesia de face e corpo do mesmo lado sugere lesão acima do bulbo, no tálamo ou no córtex contralateral, sem Horner nem paresia do palato.

B) Hipoalgesia na hemiface esquerda e no hemicorpo direito
Errada. Inverte os lados: o trato trigeminal espinhal leva a face do mesmo lado da lesão, e o espinotalâmico, o corpo do lado oposto.

C) Hipoalgesia na hemiface direita e no hemicorpo esquerdo CORRETA
Correta. O bulbo lateral contém o trigêmeo espinhal (face ipsilateral) e o espinotalâmico (corpo contralateral).

D) Perda proprioceptiva no hemicorpo esquerdo ARMADILHA
Errada. É achado do bulbo medial (lemnisco medial), que viria com hemiparesia e desvio da língua, ausentes aqui.

Para levar. Lesão bulbar lateral: Horner, paresia do palato, ataxia e hipoalgesia da face do mesmo lado, com hipoalgesia do corpo do lado oposto. Lesão bulbar medial: hemiparesia e perda proprioceptiva contralaterais, com a língua desviada para o lado da lesão.

Kim JS. Pure lateral medullary infarction: clinical-radiological correlation of 130 acute, consecutive patients. Brain 2003; 2021 AHA/ASA Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and TIA (dissecção cervical).

Revisa: Achado esperado em neurologia: da síndrome topográfica ao exame (UERJ cobra síndromes de tronco)

7

Cardiologia · Síndrome de Holt-Oram: a comunicação interatrial é ostium secundum, e o ECG mostra BRD incompleto com eixo à direita

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 24 anos procura atendimento por cansaço aos esforços e palpitações há 1 ano. Desde o nascimento tem o polegar direito com três falanges, alinhado aos demais dedos, e hipoplasia do rádio direito; a mãe tem alteração semelhante na mão e 'um sopro no coração'. O irmão mais novo tem síndrome de Down e foi operado na infância de defeito do septo atrioventricular. Ao exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 88 bpm, impulsão sistólica paraesternal esquerda, sopro sistólico ejetivo 2+/6 no foco pulmonar e desdobramento amplo de B2 que não varia com a respiração. Ecocardiograma solicitado, ainda não realizado. O achado eletrocardiográfico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

tem o polegar direito com três falanges, alinhado aos demais dedos, e hipoplasia do rádio direito

Resolução. O irmão com síndrome de Down operado de defeito do septo atrioventricular é verdadeiro e puxa para a comunicação interatrial ostium primum, cujo ECG tem BRD incompleto com eixo desviado à esquerda, porque o defeito desloca o sistema de condução. Mas o defeito do irmão não se herda por ela: o que é dela é o polegar trifalângico com hipoplasia radial, que a mãe também tem, com cardiopatia. É a síndrome de Holt-Oram (mão e coração, autossômica dominante, gene TBX5), cuja lesão mais frequente é a comunicação interatrial ostium secundum. O desdobramento fixo de B2 e o sopro ejetivo pulmonar por hiperfluxo confirmam a sobrecarga de volume do ventrículo direito; no ostium secundum o ECG mostra BRD incompleto (rSR' em V1) com eixo desviado à direita. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau também é frequente na síndrome.

A) Sobrecarga ventricular esquerda com strain
Errada. Seria esperada em estenose aórtica ou hipertensão; a sobrecarga aqui é do ventrículo direito.

B) PR curto com onda delta
Errada. Pré-excitação explicaria palpitações, mas não o desdobramento fixo de B2 nem a anomalia do membro superior.

C) BRD incompleto com eixo desviado à direita CORRETA
Correta. Holt-Oram cursa com CIA ostium secundum, que dá BRD incompleto com eixo à direita.

D) BRD incompleto com eixo desviado à esquerda ARMADILHA
Errada. É o ECG do ostium primum e do defeito do septo atrioventricular, do irmão com síndrome de Down; não é a lesão da síndrome mão-coração.

Para levar. Anomalia do polegar ou do rádio com cardiopatia é Holt-Oram, e a lesão é CIA ostium secundum: BRD incompleto com eixo à direita. Eixo à esquerda é ostium primum, da síndrome de Down.

2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease; 2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease.

Revisa: S4 q38: CIA ostium secundum x primum pelo eixo, partindo de uma síndrome genética

---

8

Nefrologia · Ataxia, tremor grosseiro e confusão na idosa em lítio estável semanas após anti-hipertensivo novo: litemia antes da imagem

Dado omitido **Gabarito C**

Mulher de 68 anos, com transtorno bipolar estável há 10 anos em uso de carbonato de lítio 900 mg/dia (última litemia de 0,8 mEq/L há 6 meses), é trazida pela filha por tremor grosseiro das mãos, marcha atáxica, fala arrastada e confusão progressivos há 5 dias. Há 3 semanas a clínica trocou a anlodipina por losartana e hidroclorotiazida 25 mg iniciada há 3 semanas no mesmo comprimido. PA 134/80 mmHg, FC 62 bpm, afebril, sem rigidez de nuca, sem déficit motor focal; mioclonias multifocais. Sódio 134 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL (basal 1,0), glicemia 110 mg/dL, cálcio 9,8 mg/dL. O exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

losartana e hidroclorotiazida 25 mg iniciada há 3 semanas

Resolução. Ataxia, disartria e confusão numa idosa hipertensa fazem pensar em AVC de fossa posterior, e a ressonância parece o próximo passo. A ausência de déficit focal, o tremor grosseiro, as mioclonias e a instalação em dias, porém, compõem neurotoxicidade por lítio, e o caso esconde a causa na troca de anti-hipertensivo: o tiazídico aumenta a reabsorção proximal de sódio e de lítio, e o bloqueador do receptor de angiotensina reduz a filtração, juntos elevando a litemia em semanas. A creatinina subindo reforça. A litemia sérica é o exame que define gravidade e conduta (suspensão, hidratação e, conforme critérios, diálise); intoxicação crônica pode ter sintomas importantes com níveis apenas moderadamente altos.

A) Ressonância magnética de crânio ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a ressonância entraria com déficit focal ou instalação súbita; aqui o quadro é difuso e há droga que eleva o lítio.

B) Eletroencefalograma
Errada. O eletroencefalograma mostra lentificação inespecífica e não define a causa nem a conduta.

C) Litemia sérica CORRETA
Correta. Neurotoxicidade após tiazídico e bloqueador de angiotensina: a litemia confirma a intoxicação crônica e guia o tratamento.

D) Punção lombar
Errada. Sem febre e sem rigidez de nuca não há suspeita de meningoencefalite que justifique punção primeiro.

Para levar. Tiazídico, IECA ou bloqueador de angiotensina e anti-inflamatório elevam a litemia em semanas: alteração neurológica difusa em usuário de lítio após droga nova pede litemia primeiro.

Gitlin M. Lithium side effects and toxicity. Int J Bipolar Disord 2016; EXTRIP workgroup recommendations for lithium poisoning (Decker BS et al., 2015).

Revisa: S1 q10 e S3 q16: droga em uso cruzada com o lítio, agora a interação com anti-hipertensivo escondida na troca de receita

---

9

Reumatologia · Artralgia de mãos com fator reumatoide muito alto, púrpura e C4 indetectável em ex-usuária de drogas injetáveis: vasculite crioglobulinêmica

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Mulher de 58 anos, ex-usuária de drogas injetáveis, tem há 8 meses dor nas pequenas articulações das mãos e nos joelhos, sem edema articular, além de manchas avermelhadas e elevadas nas pernas, que surgem em surtos e deixam pigmentação ocre, e formigamento nos pés. Ao exame, púrpura palpável nos membros inferiores, sem sinovite, hipoestesia em bota. Fator reumatoide 380 UI/mL, anti-CCP negativo, C3 92 mg/dL (90 a 180), C4 de 3 mg/dL (VR 10 a 40), ANCA negativo, ALT 1,5 vez o limite superior. Creatinina 1,3 mg/dL, hematúria dismórfica e proteinúria de 0,9 g/24h. Radiografia de mãos sem erosões. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

C4 de 3 mg/dL (VR 10 a 40)

Resolução. Dor em pequenas articulações das mãos com fator reumatoide muito alto parece artrite reumatoide, e púrpura com neuropatia seria a vasculite reumatoide. Mas não há sinovite nem erosões, o anti-CCP é negativo e a vasculite reumatoide aparece em doença erosiva de longa data, não antes da artrite. O fator reumatoide alto aqui é a atividade de IgM monoclonal ou policlonal da crioglobulina mista, e o consumo seletivo de C4 com C3 normal é o padrão dela. Púrpura palpável em surtos, artralgia, neuropatia sensitiva, glomerulonefrite e a exposição de risco para hepatite C, com transaminase alterada, compõem a vasculite crioglobulinêmica. O passo seguinte é pesquisar crioglobulinas e HCV RNA; o tratamento é antiviral de ação direta, com rituximabe se houver acometimento grave.

A) Artrite reumatoide com vasculite ARMADILHA

Errada. É a armadilha do fator reumatoide: sem sinovite, erosões ou anti-CCP não há artrite reumatoide, e a vasculite reumatoide surge na doença antiga e erosiva.

B) Vasculite crioglobulinêmica CORRETA

Correta. Púrpura, artralgia, neuropatia, glomerulonefrite, fator reumatoide alto e C4 muito baixo com C3 normal.

C) Poliangeíte microscópica

Errada. A poliangeíte microscópica tem ANCA positivo na maioria e não consome complemento.

D) Vasculite por IgA

Errada. A vasculite por IgA dá púrpura e nefrite, mas sem fator reumatoide alto nem consumo de C4.

Para levar. Fator reumatoide alto com C4 muito baixo, púrpura, neuropatia e glomerulonefrite é crioglobulinemia mista, em geral pelo HCV; o fator reumatoide é da crioglobulina, e não de artrite reumatoide.

Cacoub P et al. Cryoglobulinemia vasculitis. Am J Med 2015; KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Prevention, Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Hepatitis C in CKD.

Revisa: S2 q4 e S3 q27: rótulo do autoanticorpo; o fator reumatoide puxando para artrite reumatoide

---

10 Oncologia · Histerectomia por mioma em quem teve NIC 3 tratada: manter o rastreamento da cúpula vaginal

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 52 anos, assintomática, comparece à consulta de rotina. Fez histerectomia total abdominal há 2 anos por miomatose uterina com sangramento, e o histopatológico do útero mostrou leiomiomas, com colo uterino sem neoplasia intraepitelial. Há 9 anos foi submetida a conização por lesão intraepitelial escamosa de alto grau (NIC 3), com margens livres, e teve dois controles citológicos normais depois disso. Vida sexual ativa, parceiro fixo. Nunca fumou. Quanto ao rastreamento do câncer do colo do útero, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

conização por lesão intraepitelial escamosa de alto grau (NIC 3)

Resolução. A histerectomia total por doença benigna, com colo sem neoplasia no histopatológico, é verdadeira e é justamente o cenário em que o rastreamento se encerra, o que torna essa resposta atraente. A regra, porém, tem uma condição: vale para quem não tem antecedente de lesão de alto grau. Quem teve NIC 2 ou 3 tratada mantém risco aumentado de neoplasia do trato genital inferior, incluindo a vagina, por cerca de 20 anos após o tratamento, mesmo com histerectomia posterior. Por isso a recomendação é manter o rastreamento da cúpula vaginal, no intervalo e com o método do programa, e não interromper. Colposcopia anual é investigação de exame alterado, e não rastreamento.

A) Encerrar o rastreamento ARMADILHA
Errada. É a armadilha: encerrar vale para histerectomia por doença benigna sem antecedente de lesão de alto grau.

B) Manter rastreamento da cúpula vaginal CORRETA
Correta. Antecedente de NIC 3 tratada mantém o rastreamento na cúpula vaginal, mesmo após histerectomia por mioma.

C) Colposcopia anual da cúpula
Errada. Colposcopia é exame de investigação de resultado alterado, e não método de rastreamento periódico.

D) Rastrear só se houver sangramento
Errada. Rastreamento é feito na assintomática; esperar sangramento é diagnóstico tardio.

Para levar. Histerectomia total por doença benigna encerra o rastreamento do colo, exceto em quem teve lesão de alto grau: essa mantém o rastreamento da cúpula vaginal.

INCA: Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (2016) e Diretrizes de rastreamento com teste de DNA-HPV (2024); ACS Cervical Cancer Screening Guideline (2020).

Revisa: S3 q34: rastreamento após histerectomia, agora pela exceção (NIC 3 prévia) à regra de encerrar

---

11 Infectologia · Neutropenia febril persistente sob profilaxia com posaconazol: galactomanana negativa não dispensa a TC de tórax

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 44 anos, em indução para leucemia mieloide aguda, está internado com neutrófilos de 60/mm³ há 12 dias, em profilaxia com posaconazol. Iniciou febre há 5 dias e recebe cefepima desde então; a febre persiste, com picos de 38,9 °C, sem hipotensão. Há 1 dia tem tosse seca discreta, sem dispneia; SpO2 96% em ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações. Mucosite oral leve, cateter sem sinais flogísticos, abdome indolor. Hemoculturas seriadas negativas, urocultura negativa. Radiografia de tórax sem alterações. Galactomanana sérica de ontem: índice 0,2 (negativa). Creatinina 0,8 mg/dL. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

em profilaxia com posaconazol

Resolução. Febre que persiste além de 4 a 7 dias de antibiótico de amplo espectro num neutropênico de alto risco obriga a procurar infecção fúngica invasiva, e o pulmão é o primeiro lugar. A galactomanana negativa parece tranquilizar, e repeti-la soa prudente, mas a profilaxia com antifúngico ativo contra fungos filamentosos reduz muito a sensibilidade do teste, que não serve para excluir aspergilose nesse contexto. A radiografia normal também não exclui: a TC de tórax mostra nódulos, sinal do halo e consolidações que a radiografia não vê, e é o exame que orienta broncoscopia e troca de antifúngico. Sem dor abdominal, sem alteração hepática e com hemoculturas negativas, ultrassonografia e ecocardiograma não são a prioridade.

A) Ecocardiograma transesofágico
Errada. Seria o exame para bacteremia persistente por Staphylococcus aureus ou Candida; as hemoculturas são negativas.

B) TC de tórax CORRETA
Correta. Febre persistente no 5º dia de antibiótico em neutropênico de alto risco: TC de tórax mesmo com radiografia normal.

C) Repetir a galactomanana sérica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: sob posaconazol a galactomanana perde sensibilidade, e repeti-la atrasa o diagnóstico.

D) Ultrassonografia de abdome
Errada. Útil na suspeita de candidíase hepatoesplênica, que aparece na recuperação dos neutrófilos e com fosfatase alcalina elevada, nada disso presente.

Para levar. No neutropênico de alto risco com febre persistente, a TC de tórax vem antes de tudo; galactomanana negativa sob profilaxia antifúngica ativa contra fungos filamentosos não exclui aspergilose.

IDSA Clinical Practice Guideline for Antimicrobial Use in Neutropenic Patients with Cancer (Freifeld et al., 2011); IDSA Aspergillosis Guideline 2016; ECIL-8 (2022).

Revisa: S4 q13: febre persistente na neutropenia de alto risco pede TC de tórax, e o exame negativo plantado não a dispensa

---

12 Endocrinologia · Hipocalcemia após paratireoidectomia por osteíte fibrosa com fósforo baixo e PTH normal: fome óssea, cálcio venoso e calcitriol

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 54 anos, com hiperparatireoidismo primário grave (cálcio 12,8 mg/dL, PTH 1.480 pg/mL, fosfatase alcalina 1.120 U/L) e lesões líticas nos ossos longos compatíveis com tumores marrons, foi submetida à retirada de adenoma de paratireoide de 4 g, com as demais glândulas normais. No terceiro dia de pós-operatório, refere parestesias periorais e nas mãos, com sinal de Chvostek presente. Cálcio total 7,1 mg/dL (albumina 3,9 g/dL), fósforo 1,8 mg/dL (2,5 a 4,5), magnésio 1,5 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 58 pg/mL (15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PTH 58 pg/mL

Resolução. O magnésio baixo atrai como causa, mas 1,5 mg/dL não costuma bloquear a secreção de PTH, que só falha com magnésio bem mais baixo, e o PTH aqui é normal. O PTH presente afasta o hipoparatireoidismo pós-operatório. Hipocalcemia com fósforo também baixo após a retirada de um PTH muito elevado, em paciente com doença óssea grave e fosfatase alcalina alta, é a fome óssea: o osso desmineralizado capta avidamente cálcio, fósforo e magnésio quando o estímulo do PTH cessa. No hipoparatireoidismo, ao contrário, o fósforo sobe. O tratamento é cálcio venoso para a hipocalcemia sintomática, calcitriol para aumentar a absorção intestinal e reposição de magnésio associada; o fosfato venoso deve ser evitado, porque precipita com o cálcio e agrava a hipocalcemia.

A) Hipoparatireoidismo / calcitriol isolado
Errada. O hipoparatireoidismo teria PTH baixo ou indetectável e fósforo alto; aqui o PTH é 58 pg/mL e o fósforo é baixo.

B) Hipomagnesemia / sulfato de magnésio isolado ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a hipomagnesemia é leve, contribui e deve ser corrigida, mas não explica o quadro, e magnésio isolado não basta.

C) Fome óssea / cálcio venoso e calcitriol CORRETA
Correta. Fome óssea (fósforo baixo e PTH presente após retirada de PTH muito alto) pede cálcio venoso e calcitriol, com magnésio associado.

D) Fome óssea / fosfato venoso e cálcio
Errada. O diagnóstico está certo, mas fosfato venoso precipita com o cálcio e piora a hipocalcemia.

Para levar. Hipocalcemia pós-paratireoidectomia: fósforo baixo e PTH presente é fome óssea (cálcio venoso e calcitriol); fósforo alto e PTH baixo é hipoparatireoidismo.

Witteveen JE et al. Hungry bone syndrome: still a challenge in the post-operative management of primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2013; Bilezikian JP et al. Fifth International Workshop on Primary Hyperparathyroidism (2022).

Revisa: S2 q63: fome óssea contra hipomagnesemia e hipoparatireoidismo; agora após paratireoidectomia, com a conduta na grade

---

13 Pneumologia · Derrame com ADA alto em contato de tuberculose: glicose muito baixa e predomínio neutrofílico apontam derrame parapneumônico complicado

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 49 anos, etilista, cujo irmão, com quem mora, termina tratamento para tuberculose pulmonar, procura atendimento por febre de 38,7 °C, tosse com expectoração amarelada e dor pleurítica à direita há 9 dias. Fez amoxicilina por 5 dias, sem melhora. Ao exame, FR 24 irpm, SpO2 93%, macicez e murmúrio abolido no terço inferior do hemitórax direito. Leucócitos 19.400/mm³. Radiografia: consolidação em base direita com derrame moderado. Toracocentese: líquido turvo, não purulento, pH 6,95, glicose 14 mg/dL (glicemia 112 mg/dL), LDH 2.900 U/L, proteína 4,6 g/dL, 12.800 células/mm³ com neutrófilos 88%, ADA 92 U/L; Gram sem bactérias. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

neutrófilos 88%

Resolução. O irmão com tuberculose e o ADA de 92 U/L são verdadeiros e empurram para tuberculose pleural. Mas o ADA sobe também no empiema e no derrame parapneumônico complicado, porque os neutrófilos ativados liberam a enzima, e ele só sustenta tuberculose num exsudato linfocítico. Aqui o líquido tem 88% de neutrófilos, pH abaixo de 7,20, glicose abaixo de 60 mg/dL e LDH muito alta, todos critérios de derrame parapneumônico complicado, num quadro de pneumonia que não respondeu ao antibiótico oral. Glicose tão baixa é rara na tuberculose pleural e aparece no empiema e no derrame reumatoide, mas este último seria crônico, sem pneumonia e em quem tem artrite. A conduta é drenagem torácica e antibiótico com cobertura de anaeróbios.

A) Tuberculose pleural ARMADILHA
Errada. É a armadilha do contato e do ADA: a tuberculose pleural dá exsudato linfocítico, e não neutrofílico com pH e glicose tão baixos.

B) Derrame parapneumônico complicado CORRETA
Correta. Pneumonia com líquido neutrofílico, pH abaixo de 7,20 e glicose abaixo de 60 mg/dL: derrame complicado, e o ADA alto vem dos neutrófilos.

C) Derrame pleural reumatoide
Errada. Também tem glicose muito baixa, mas é crônico, ocorre em quem já tem artrite reumatoide e não acompanha pneumonia aguda.

D) Derrame parapneumônico não complicado
Errada. O não complicado tem pH acima de 7,20 e glicose acima de 60 mg/dL; os dois critérios estão violados.

Para levar. ADA alto só sugere tuberculose em exsudato linfocítico; com neutrófilos, pH abaixo de 7,20 e glicose abaixo de 60 mg/dL, o diagnóstico é derrame parapneumônico complicado.

BTS Guideline for Pleural Disease (2023); Diretrizes Brasileiras para Tuberculose da SBPT (2009) e Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019).

Revisa: S3 q57: glicose pleural e celularidade contra o ADA alto com contato de tuberculose

---

14 Hematologia · Pneumocistose grave com alergia grave à sulfa e deficiência de G6PD: pentamidina intravenosa

Negativo no meio | Gabarito C

Homem de 39 anos, vivendo com HIV, sem tratamento antirretroviral, CD4 de 42 células/mm³, chega com tosse seca e dispneia progressiva há 3 semanas. Teve síndrome de Stevens-Johnson por sulfametoxazol-trimetoprima há 2 anos. FR 30 irpm, SpO2 86% em ar ambiente, PaO2 de 56 mmHg. TC com vidro fosco difuso bilateral; PCR para Pneumocystis jirovecii positiva no escarro induzido. Em internação anterior, atividade de G6PD de 8% do normal, dosada fora de crise hemolítica. Creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 98 mg/dL, ECG com QTc de 430 ms. Prednisona já foi iniciada. O tratamento antimicrobiano mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

atividade de G6PD de 8% do normal

Resolução. Com a sulfa proibida pela síndrome de Stevens-Johnson, a alternativa de manual para pneumocistose moderada a grave é primaquina com clindamicina. A primaquina, porém, é oxidante e provoca hemólise grave na deficiência de G6PD, documentada aqui fora de crise; a dapsona tem o mesmo problema e ainda reação cruzada com sulfa. A atovaquona tem absorção irregular e só é opção na forma leve a moderada, e a PaO2 de 56 mmHg define doença grave. Resta a pentamidina intravenosa, com monitorização de glicemia, função renal, pâncreas e QT, que estão normais no início.

A) Atovaquona oral
Errada. A atovaquona é reservada à forma leve a moderada; PaO2 abaixo de 70 mmHg é grave.

B) Dapsona com trimetoprima
Errada. Dapsona é oxidante e tem reação cruzada com sulfa; contraindicada pelos dois dados.

C) Pentamidina intravenosa CORRETA
Correta. Forma grave, sulfa e oxidantes proibidos: pentamidina intravenosa, vigiando glicemia, creatinina e QT.

D) Primaquina com clindamicina ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a alternativa na forma grave sem deficiência de G6PD, mas a primaquina causa hemólise oxidativa.

Para levar. Antes de primaquina ou dapsona, cheque a G6PD; na pneumocistose grave com sulfa e oxidantes proibidos, a opção é pentamidina intravenosa.

NIH/CDC/IDSA Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults with HIV, Pneumocystis (atualização 2024); Ministério da Saúde, PCDT HIV em adultos (2024).

Revisa: S1 q87 e S1 q61: G6PD como droga em uso a cruzar, agora escolhendo o antimicrobiano

---

15

Cardiologia · Marca-passo com pausas sem espícula durante esforço de braços: inibição por miopotenciais (oversensing)

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 74 anos tem marca-passo unicameral ventricular, programado em VVI a 60 bpm, implantado há 2 anos por bloqueio atrioventricular total, com eletrodo de fixação ativa e gerador no peitoral esquerdo. Há 1 mês tem tonturas e duas pré-síncopes, ambas enquanto carregava sacolas de compras ou varria a casa. Usa hidroclorotiazida e losartana, que o clínico suspeita estarem causando hipotensão postural. Holter: fora dos episódios, ritmo de marca-passo a 60 bpm, cada espícula seguida de QRS largo. Durante os sintomas, pausas de até 3,4 s sem nenhuma espícula, coincidindo com artefato de alta frequência na linha de base; não há espículas soltas sem QRS. Telemetria: bateria com tempo estimado de 7 anos e impedância do eletrodo estável. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pausas de até 3,4 s sem nenhuma espícula

Resolução. Pausa em portadora de marca-passo e bloqueio total faz pensar em falha de captura, e o diurético oferece o rótulo de hipotensão postural. Mas falha de captura mostra a espícula sem QRS depois dela, e o Holter diz que não há espículas soltas: nas pausas o aparelho simplesmente não disparou. Um marca-passo em modo inibido deixa de disparar quando 'enxerga' atividade que interpreta como QRS próprio; o artefato de alta frequência no momento do esforço com os braços é o miopotencial do peitoral, que o eletrodo capta. Isso é sensibilidade excessiva (oversensing), que se corrige reduzindo a sensibilidade ou mudando a polaridade para bipolar. Falha de sensibilidade faria o oposto (espículas a mais, inclusive sobre QRS próprio), e esgotamento da bateria reduziria a frequência de estimulação de forma contínua, com telemetria alterada.

A) Sensibilidade excessiva (oversensing) CORRETA
Correta. Pausas sem espícula durante o esforço dos braços, com artefato na linha de base, são inibição por miopotenciais.

B) Falha de sensibilidade (undersensing)
Errada. Produziria espículas a mais, fora de hora, e não pausas; é o defeito oposto.

C) Falha de captura ventricular ARMADILHA
Errada. Mostraria espículas que não são seguidas de QRS; aqui não há espícula nas pausas.

D) Esgotamento da bateria
Errada. Daria queda progressiva da frequência programada e telemetria anormal; a bateria tem 7 anos estimados.

Para levar. No marca-passo, pausa sem espícula é sensibilidade excessiva (o aparelho se inibe); espícula sem QRS é falha de captura; espícula a mais, fora de hora, é falha de sensibilidade.

2021 ESC Guidelines for cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy; Diretrizes Brasileiras de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis, SBC 2023.

Revisa: S2 q28: defeito do marca-passo lido pela relação espícula e QRS (agora a pausa sem espícula)

16

Grade X / Y | Gabarito A

Gastroenterologia e hepatologia · Acalasia tipo I na manometria em tabagista idoso com disfagia curta e cárdia resistente: pseudoacalasia antes de qualquer miotomia

Homem de 69 anos, tabagista de 50 maços-ano, procura atendimento por disfagia para sólidos e líquidos com regurgitação noturna e perda de 10 kg em 4 meses. Nega pirose prévia. Ao exame, emagrecido, sem linfonodomegalias palpáveis, abdome sem massas. Esofagografia: esôfago dilatado com afilamento distal em bico de pássaro. Manometria de alta resolução: relaxamento incompleto da junção esofagogástrica com aperistalse sem pressurização, padrão de acalasia tipo I. Endoscopia: mucosa sem lesões, com resistência firme à passagem do aparelho pela cárdia, que só cede com pressão. A hipótese principal e o próximo passo são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

perda de 10 kg em 4 meses

Resolução. A manometria preenche critério de acalasia, e o tratamento moderno (miotomia endoscópica) parece o passo natural. A manometria, porém, não distingue acalasia idiopática de pseudoacalasia, em que um tumor da cárdia ou infiltração extrínseca produz o mesmo padrão. Os sinais de alarme são idade acima de 60 anos, história curta (menos de 1 ano), perda de peso importante e resistência à passagem do endoscópio pela cárdia; aqui estão todos, num tabagista. Antes de dilatar ou cortar, a ecoendoscopia da cárdia e a TC de tórax e abdome buscam o tumor que a mucosa normal não mostra.

A) Pseudoacalasia / ecoendoscopia e TC CORRETA
Correta. Idoso, disfagia de 4 meses, emagrecimento e cárdia resistente: pseudoacalasia até prova em contrário, com ecoendoscopia e TC.

B) Acalasia idiopática / miotomia endoscópica ARMADILHA
Errada. Seria a escolha na acalasia idiopática confirmada, sobretudo tipo III; aqui operar sem excluir tumor atrasa o diagnóstico de câncer.

C) Acalasia idiopática / dilatação pneumática
Errada. A dilatação na pseudoacalasia não trata a causa e pode perfurar uma cárdia infiltrada.

D) Esofagite eosinofílica / biópsias seriadas
Errada. Esofagite eosinofílica dá impactação alimentar em jovem atópico, sem padrão manométrico de acalasia.

Para levar. Acalasia na manometria com idade acima de 60, disfagia de menos de 1 ano, emagrecimento e cárdia que resiste ao aparelho pede ecoendoscopia e TC antes do tratamento.

ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Achalasia (2020); Chicago Classification v4.0 (2021).

Revisa: S3 q6: pseudoacalasia pelos sinais de alarme, agora em acalasia tipo I e com grade hipótese / próximo passo

---

17

Neurologia · Déficit focal no 7º dia de hemorragia subaracnóidea com sódio baixo: isquemia tardia por vasoespasmo, e não hiponatremia

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Mulher de 49 anos está no 7º dia de hemorragia subaracnóidea por aneurisma da artéria comunicante anterior, embolizado no 1º dia, com sangue espesso nas cisternas e nos ventrículos laterais à TC inicial. Usa nimodipina

60 mg de 4/4 horas e está euvolêmica. Hoje, às 10 horas, ficou sonolenta e passou a ter dificuldade para encontrar palavras e fraqueza no braço e na face à direita. Afebril, PA 138 × 82 mmHg. Sódio 129 mEq/L (132 mEq/L na véspera), glicemia 118 mg/dL. TC de crânio: sem novo sangramento, ventrículos com as mesmas dimensões da TC de 2 dias antes. Doppler transcraniano: velocidade média de 210 cm/s na artéria cerebral média esquerda, índice de Lindegaard de 5,8. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

índice de Lindegaard de 5,8

Resolução. O sódio de 129 é verdadeiro e frequente na hemorragia subaracnóidea, e quem procura causa metabólica para a sonolência marca hiponatremia. Mas sódio de 129, caindo pouco, não produz afasia e hemiparesia; déficit focal novo entre o 4º e o 14º dia, num paciente com muito sangue nas cisternas (Fisher modificado alto), é isquemia cerebral tardia por vasoespasmo até prova em contrário. O Doppler confirma: velocidade média acima de 200 cm/s na cerebral média é vasoespasmo grave, e o índice de Lindegaard acima de 3 (acima de 6 é grave) separa vasoespasmo de hiperfluxo. A TC sem sangue novo afasta ressangramento, raro após embolização, e ventrículos inalterados afastam hidrocefalia. A conduta é manter euvolemia, induzir hipertensão se não houver contraindicação e considerar angiografia com terapia endovascular; a hiponatremia deve ser corrigida, sem restringir água.

A) Hidrocefalia aguda
Errada. Rebaixaria a consciência com ventrículos maiores; a TC mostra ventrículos inalterados e o déficit é focal.

B) Ressangramento do aneurisma
Errada. Daria piora súbita com sangue novo na TC; o aneurisma foi embolizado e a TC não mostra sangramento.

C) Isquemia tardia por vasoespasmo CORRETA
Correta. Déficit focal no 7º dia, velocidade de 210 cm/s e Lindegaard de 5,8 definem vasoespasmo sintomático.

D) Hiponatremia sintomática ARMADILHA
Errada. Sódio de 129 pode dar sonolência, mas não afasia com hemiparesia; é achado associado, e não a causa do déficit focal.

Para levar. Déficit focal entre o 4º e o 14º dia de hemorragia subaracnóidea é vasoespasmo até prova em contrário; a hiponatremia acompanha, mas não explica afasia e hemiparesia, e não se trata com restrição hídrica.

2023 AHA/ASA Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage; Neurocritical Care Society guidelines for SAH, 2023.

Revisa: UERJ pouco explorado: HSA e vasoespasmo (com rótulo verdadeiro de hiponatremia)

---

18 Nefrologia · TC com contraste intravenoso ambulatorial com TFGe estável de 26: abaixo de 30, salina isotônica profilática

Limiar **Gabarito B**

Homem de 72 anos, com diabetes tipo 2 em uso de insulina (não usa metformina) e doença renal crônica, tem TFGe estável de 26 mL/min/1,73 m² nos últimos 12 meses. Vai fazer TC de abdome com contraste iodado

intravenoso de baixa osmolalidade para estadiar uma massa renal sólida de 4 cm. Não tem insuficiência cardíaca (fração de ejeção de 58%), está euvolêmico, PA 136/78 mmHg, sem anti-inflamatórios. Não há alternativa diagnóstica sem contraste com a mesma acurácia. Quanto à prevenção de lesão renal associada ao contraste, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

TFGe estável de 26 mL/min/1,73 m²

Resolução. Quem fixou que contraste intravenoso não pede profilaxia com TFGe em torno de 45 tende a estender a regra a todos. O consenso do ACR com a National Kidney Foundation estabelece o limiar: com TFGe de 45 ou mais não há risco relevante; entre 30 e 44 a profilaxia é individualizada; abaixo de 30 sem diálise, ou com lesão renal aguda, a hidratação com salina isotônica intravenosa antes e depois do exame é indicada, desde que não haja contraindicação por sobrecarga de volume. Este paciente está abaixo de 30, euvolêmico e sem insuficiência cardíaca. N-acetilcisteína e bicarbonato não mostraram benefício, e hemodiálise após o exame não protege o rim.

A) Nenhuma profilaxia específica ARMADILHA
Errada. É a armadilha do limiar: nenhuma profilaxia vale para TFGe de 45 ou mais; abaixo de 30 a hidratação é indicada.

B) Salina isotônica antes e depois CORRETA
Correta. TFGe abaixo de 30 sem diálise, sem contraindicação de volume: salina isotônica intravenosa antes e depois.

C) N-acetilcisteína oral
Errada. A N-acetilcisteína não reduziu lesão renal nem diálise no ensaio PRESERVE.

D) Hemodiálise após o exame
Errada. A hemodiálise profilática não previne lesão renal e expõe a riscos de acesso.

Para levar. Contraste iodado intravenoso: TFGe de 45 ou mais, nada; 30 a 44, individualizar; abaixo de 30 ou lesão renal aguda, salina isotônica se não houver sobrecarga.

ACR-NKF Consensus Statement on Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease (Davenport MS et al., Radiology 2020); ACR Manual on Contrast Media (2024); Weisbord SD et al. PRESERVE, NEJM 2018.

Revisa: S2 q80: limiar de TFGe para profilaxia do contraste, agora abaixo de 30, onde a resposta se inverte

---

19 Infectologia · Celulite não purulenta com sinais sistêmicos no diabético: betalactâmico antiestreptocócico intravenoso, e não cobertura de pé diabético

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 61 anos, diabético tipo 2 há 15 anos (HbA1c 8,1%), em uso de metformina e gliclazida, procura o pronto-socorro por febre de 38,6 °C, calafrios e vermelhidão na perna esquerda há 2 dias, que começou na face anterior da tíbia e se estende até a metade da coxa. Tem maceração e fissuras entre o quarto e o quinto dedos do mesmo pé. Ao exame, FC 104 bpm, PA 128 × 76 mmHg, placa eritematosa quente e dolorosa de bordas mal definidas, sem bolhas, sem necrose, sem flutuação, sem secreção purulenta e sem crepitação; dor proporcional ao achado. Pulsos pediosos palpáveis, monofilamento sensível, sem úlcera nos pés. Leucócitos 15.800/mm³,

creatinina 1,0 mg/dL. Ultrassonografia de partes moles: edema subcutâneo difuso, sem coleção. Nunca foi internado e não usou antibiótico no último ano. A conduta antimicrobiana mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sem flutuação, sem secreção purulenta e sem crepitação

Resolução. O diabetes de longa data é verdadeiro e puxa para a lógica do pé diabético infectado, com cobertura ampla de Gram-negativos, anaeróbios e estafilococo resistente. Mas não há úlcera, a neuropatia e a isquemia foram afastadas e a porta de entrada é intertrigo interdigital, o que coloca o quadro na categoria de celulite não purulenta. Sem pus, sem abscesso e sem coleção no ultrassom, o agente é o estreptococo beta-hemolítico, e o antimicrobiano é um betalactâmico com boa ação antiestreptocócica. A febre, a taquicardia e a leucocitose definem infecção moderada, que pede via intravenosa, e não esquema de amplo espectro: este fica para sinais de fasciite (dor desproporcional, bolhas, necrose, crepitação, instabilidade) ou para o paciente imunodeprimido grave. O intertrigo deve ser tratado junto para reduzir recidiva.

A) Cefazolina intravenosa CORRETA

Correta. Celulite não purulenta com sinais sistêmicos sem critérios de gravidade: betalactâmico antiestreptocócico intravenoso.

B) Sulfametoxazol-trimetoprima oral

Errada. Seria opção oral para celulite purulenta ou abscesso drenado com suspeita de estafilococo resistente; tem cobertura antiestreptocócica pouco confiável e a via oral não serve com sinais sistêmicos.

C) Vancomicina com piperacilina-tazobactam ARMADILHA

Errada. É a armadilha do diabetes: esquema para infecção necrosante, choque ou pé diabético grave, nada disso presente neste caso.

D) Ciprofloxacino com clindamicina

Errada. Associação usada no pé diabético com úlcera infectada polimicrobiana; aqui não há úlcera e a quinolona não é droga antiestreptocócica de escolha.

Para levar. Na celulite, o que define o agente é ter ou não pus: sem pus, é estreptococo e betalactâmico; os sinais sistêmicos mudam a via, e não o espectro.

IDSA Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections (Stevens et al., 2014, mantidas em vigor); IWGDF/IDSA Guidelines on Diabetes-related Foot Infections 2023.

Revisa: S1 q68: sem pus e sem coleção o agente é estreptococo, e o rótulo (aqui o diabetes) não justifica cobertura ampla

---

20 Reumatologia · Sjögren primário com secura e fadiga, sem doença extraglandular: tratamento sintomático com agonista muscarínico, sem imunomodulador

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 48 anos tem diagnóstico recente de síndrome de Sjögren primária: secura ocular e oral há 2 anos, teste de Schirmer de 3 mm em 5 minutos, anti-Ro positivo e biópsia de glândula salivar menor com escore de focos de 2. Queixa-se de boca seca que atrapalha a fala e de cansaço. Nega artralgia, artrite, púrpura, aumento de parótidas, adenomegalia, dispneia ou parestesias. Exame físico normal, exceto mucosa oral seca. Hemograma, VHS, creatinina, urina tipo 1, C3, C4 e eletroforese de proteínas normais; crioglobulinas negativas. Função pulmonar normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Nega artralgia, artrite, púrpura, aumento de parótidas, adenomegalia, dispneia ou parestesias

Resolução. Doença autoimune confirmada por anticorpo e biópsia parece pedir um imunomodulador, e a hidroxicloroquina é a escolha intuitiva. No Sjögren, porém, os imunomoduladores não melhoram a secura nem a fadiga em ensaios controlados, e a decisão de tratar sistemicamente depende da atividade extraglandular. Esta paciente não tem artrite ou artralgia (onde a hidroxicloroquina tem papel), púrpura, envolvimento pulmonar, renal ou neurológico, e os marcadores de risco de linfoma (parótidas aumentadas, complemento baixo, crioglobulinas, gamopatia) estão ausentes. O tratamento é sintomático: lubrificantes oculares e substitutos de saliva, e, com função glandular residual e secura moderada a grave, agonista muscarínico como a pilocarpina.

A) Hidroxicloroquina 400 mg/dia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a hidroxicloroquina se usa no Sjögren com artralgia ou artrite, ausentes aqui; não melhora secura nem fadiga.

B) Rituximabe em duas doses
Errada. O rituximabe fica para doença extraglandular grave, como vasculite crioglobulinêmica ou neuropatia.

C) Pilocarpina e lubrificantes CORRETA
Correta. Secura moderada a grave sem atividade sistêmica: lubrificantes e agonista muscarínico.

D) Prednisona 20 mg/dia
Errada. Glicocorticoide sistêmico é para manifestação extraglandular ativa, e não para sintomas glandulares.

Para levar. No Sjögren, trate a secura com medidas locais e agonista muscarínico; imunomodulador só com doença extraglandular ativa (hidroxicloroquina para artralgia, imunossupressão para órgão acometido).

Ramos-Casals M et al. EULAR recommendations for the management of Sjögren's syndrome with topical and systemic therapies. Ann Rheum Dis 2020; Valim V et al. Recomendações da SBR para o tratamento da síndrome de Sjögren (2015).

Revisa: S1 q36 e S2 q15: porte exagerado no estável; imunomodulação sem doença sistêmica que a justifique

---

21 Endocrinologia · Cushing ACTH-dependente com adenoma de 12 mm na ressonância e testes dinâmicos concordantes: cirurgia sem cateterismo de seios petrosos

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 38 anos, com ganho de 14 kg em 18 meses, estrias violáceas largas no abdome, equimoses fáceis, fraqueza para subir escadas, hipertensão e diabetes recentes. Cortisol salivar ao final da noite elevado em duas amostras; cortisol livre urinário três vezes o limite superior; ACTH plasmático de 62 pg/mL (10 a 60) em duas dosagens. Potássio 3,9 mEq/L. Supressão com 8 mg de dexametasona: queda de 72% do cortisol; teste com desmopressina com elevação de 55% do ACTH. Ressonância de sela com gadolínio: lesão hipocaptante de 12 mm à direita, sem invasão do seio cavernoso. TC de tórax sem nódulos. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

lesão hipocaptante de 12 mm

Resolução. Quem aprendeu que o hipercortisolismo ACTH-dependente pede cateterismo de seios petrosos tende a pedi-lo sempre. O cateterismo existe para separar a origem hipofisária da ectópica quando a imagem

não é conclusiva: ressonância normal ou com lesão pequena (abaixo de 6 a 10 mm), que pode ser incidentaloma hipofisário, presente em até 10% da população. Aqui há adenoma de 12 mm, acima do limiar de 10 mm, em mulher jovem, com ACTH apenas discretamente elevado, potássio normal e testes dinâmicos concordantes com origem hipofisária (supressão com dose alta e resposta à desmopressina). Nessa combinação, a probabilidade de doença de Cushing é muito alta e o consenso recomenda ir direto à cirurgia transesfenoidal, sem procedimento invasivo adicional. Imagem para tumor ectópico seria o caminho com hipocalemia intensa, ACTH muito alto e testes discordantes.

A) TC de tórax, abdome e pelve
Errada. A busca de tumor ectópico entra com ACTH muito alto, hipocalemia e ausência de supressão; aqui tudo aponta para a hipófise.

B) PET-CT com análogo de somatostatina
Errada. A cintilografia com análogo de somatostatina procura tumor neuroendócrino ectópico, que não é a hipótese aqui.

C) Cirurgia transesfenoidal CORRETA
Correta. Adenoma de 12 mm com testes dinâmicos concordantes dispensa o cateterismo e vai à cirurgia.

D) Cateterismo de seios petrosos inferiores ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o cateterismo é necessário quando a lesão é menor que 6 a 10 mm ou ausente, ou quando os testes discordam.

Para levar. No Cushing ACTH-dependente, adenoma hipofisário de 10 mm ou mais com testes dinâmicos concordantes vai direto à cirurgia; o cateterismo de seios petrosos fica para lesão pequena, ausente ou testes discordantes.

Fleseriu M et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update, Pituitary Society. Lancet Diabetes Endocrinol 2021.

Revisa: S1 q35: Cushing ACTH-dependente e o lugar do cateterismo de seios petrosos; agora o limiar de 10 mm o dispensa

---

22

Hematologia · Recorrência de trombose sob rivaroxabana após remédio para dor facial em choques: indução pela carbamazepina, trocar para varfarina

Droga a deduzir **Gabarito D**

Mulher de 48 anos teve tromboembolismo pulmonar não provocado há 4 meses e usa rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, sempre no jantar, com adesão confirmada pela contagem de comprimidos. Há 6 semanas, o neurologista iniciou um medicamento para crises de dor em choque na hemiface direita desencadeadas ao escovar os dentes, com boa resposta; a dose foi aumentada há 2 semanas. Agora apresenta edema doloroso da perna esquerda, e o duplex mostra trombose femoral nova. Peso 68 kg, clearance de creatinina 92 mL/min, plaquetas 210.000/mm³, sem câncer na investigação. A conduta mais adequada para a anticoagulação é:

O DADO QUE DECIDE

crises de dor em choque na hemiface direita desencadeadas ao escovar os dentes

Resolução. Recorrência com adesão confirmada sugere falha do anticoagulante, e trocar por outro anticoagulante oral direto parece a saída lógica. A pista está no medicamento para neuralgia do trigêmeo: a carbamazepina, primeira escolha, é indutora potente do CYP3A4 e da glicoproteína P, e reduz os níveis de rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigatrana a ponto de perder eficácia; trocar de um direto por outro

não resolve. A cronologia (trombose semanas após iniciar e aumentar a dose) fecha a interação. Se a carbamazepina for mantida, o anticoagulante deve ser um cujo efeito se mede e se ajusta: heparina de baixo peso como ponte e varfarina guiada pelo INR, que também sofre indução mas é titulável. Aumentar a dose do direto não tem respaldo e o filtro só entra com contraindicação à anticoagulação.

A) Aumentar a rivaroxabana para 30 mg/dia
Errada. Dobrar a dose do anticoagulante direto não compensa a indução de forma previsível e não tem respaldo em diretriz.

B) Trocar para apixabana em dose plena ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a apixabana sofre a mesma indução de CYP3A4 e glicoproteína P pela carbamazepina.

C) Implantar filtro de veia cava inferior
Errada. Filtro de cava é para quem não pode anticoagular; aqui o problema é farmacocinético e tem solução.

D) Trocar para varfarina com ponte de heparina CORRETA
Correta. Com indutor potente mantido, varfarina ajustada pelo INR com ponte de heparina garante anticoagulação mensurável.

Para levar. Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e rifampicina tornam os anticoagulantes orais diretos ineficazes: com o indutor mantido, use varfarina guiada pelo INR ou heparina de baixo peso.

EHRA Practical Guide on the use of NOACs in AF (2021); ISTH SSC Guidance on DOAC drug interactions (2024); bulas de rivaroxabana e apixabana.

Revisa: S3 q28: interação de drogas com a droga a deduzir pelo quadro, agora indutor enzimático contra anticoagulante direto

---

23

Cardiologia · Febre reumática sem cardite aos 18 anos: profilaxia secundária por 5 anos, até os 23, e não até os 21

Limiar **Gabarito A**

Homem de 19 anos teve, aos 18 anos, poliartrite migratória de grandes articulações, febre e eritema marginado, com ASLO elevada; o diagnóstico foi de febre reumática. O ecocardiograma com Doppler no surto e o repetido 6 meses depois foram normais, sem regurgitação patológica, e nunca houve sopro. Faz penicilina benzatina 1.200.000 UI a cada 21 dias desde então, sem novos surtos. Pergunta até quando deve manter a profilaxia. Pelas diretrizes vigentes, a profilaxia secundária deve ser mantida:

O DADO QUE DECIDE

O ecocardiograma com Doppler no surto e o repetido 6 meses depois foram normais

Resolução. Quem lembra da febre reumática sem cardite como 'profilaxia até os 21 anos' para no número. A regra tem duas partes e vale a que durar mais: sem cardite, até os 21 anos ou por 5 anos após o último surto. Como o surto foi aos 18 anos, os 5 anos terminam aos 23, que é mais tarde que os 21. O ecocardiograma normal no surto e no controle afasta inclusive cardite subclínica, que mudaria a categoria: com cardite e sequela leve ou ausente, a regra passa a 10 anos após o surto ou até os 25 anos; com lesão moderada ou grave, até os 40 anos ou por toda a vida.

A) Até os 23 anos CORRETA
Correta. Sem cardite, mantém-se por 5 anos após o último surto ou até os 21 anos, o que for mais longo: aqui, até os 23.

B) Até os 25 anos

Errada. Corresponde à cardite sem sequela ou com sequela leve, ausente aqui pelo ecocardiograma normal.

C) Até os 21 anos ARMADILHA

Errada. Seria o prazo se o surto tivesse ocorrido antes dos 16 anos; aos 18, os 5 anos ultrapassam os 21.

D) Até os 28 anos

Errada. Seriam 10 anos após o surto, prazo da cardite com sequela leve; não se aplica sem cardite.

Para levar. Profilaxia secundária da febre reumática: sem cardite, 5 anos após o último surto ou até os 21 (o mais longo); cardite curada ou leve, 10 anos ou até os 25; lesão moderada ou grave, até os 40 ou por toda a vida.

Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática, SBC 2009; Gerber MA et al. AHA Scientific Statement on prevention of rheumatic fever, Circulation 2009.

Revisa: S3 q24: duração da profilaxia secundária da febre reumática (agora sem cardite e com surto tardio)

24

Pneumologia · Hemorragia alveolar sem hemoptise na nefrite lúpica: DLCO que sobe e queda de hemoglobina contra pneumonite e infecção

Dado omitido **Gabarito C**

Mulher de 26 anos, com lúpus eritematoso sistêmico e nefrite classe IV em indução com micofenolato e prednisona 40 mg/dia há 5 semanas, procura o pronto-socorro por dispneia progressiva há 2 dias e tosse seca. Nega hemoptise. Temperatura 37,6 °C, FR 28 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, PA 132 × 84 mmHg, sem edema e sem turgência jugular. Hemoglobina 7,4 g/dL (era 10,1 g/dL há 4 dias), sem sinais de hemólise, sem sangramento digestivo; plaquetas 168.000/mm³, coagulograma normal. TC de tórax: vidro fosco difuso bilateral, poupando a periferia, sem derrame. DLCO de 128% do previsto (há 2 meses, 74%). Beta-D-glucana negativa. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

DLCO de 128% do previsto

Resolução. A imunossupressão intensa e o vidro fosco difuso puxam para pneumocistose, e o lúpus ativo puxa para pneumonite lúpica. Nenhuma das duas explica a queda de quase 3 g/dL de hemoglobina em 4 dias sem hemólise e sem sangramento visível, e ambas reduziriam a DLCO. A hemoglobina extravasada nos alvéolos capta monóxido de carbono e faz a DLCO subir, de modo que uma DLCO acima do previsto, ainda mais subindo em relação à anterior, é o marcador funcional de sangue alveolar recente. A ausência de hemoptise não afasta: um terço dos casos não a tem. A confirmação vem do lavado broncoalveolar com alíquotas progressivamente mais hemorrágicas, e o tratamento é pulsoterapia, com plasmaférese discutida conforme a gravidade.

A) Pneumonite lúpica aguda

Errada. Também dá vidro fosco no lúpus ativo, mas reduz a DLCO e não explica a queda de hemoglobina.

B) Pneumonia por Pneumocystis ARMADILHA

Errada. É a armadilha da imunossupressão: reduz a DLCO, não derruba a hemoglobina e a beta-D-glucana negativa a torna improvável.

C) Hemorragia alveolar difusa CORRETA

Correta. Queda de hemoglobina inexplicada, vidro fosco e DLCO acima do previsto: sangue alveolar captando monóxido de carbono.

D) Edema pulmonar por sobrecarga

Errada. Sem edema, sem turgência e sem derrame; e a sobrecarga não explica a anemia aguda nem a DLCO alta.

Para levar. Vidro fosco difuso com hemoglobina caindo e DLCO alta é hemorragia alveolar até prova em contrário, com ou sem hemoptise.

Lara AR, Schwarz MI. Diffuse Alveolar Hemorrhage. Chest 2010; EULAR recommendations for the management of SLE (2023).

Revisa: S4 q43: DLCO que sobe identifica hemorragia alveolar sem hemoptise; agora no lúpus imunossuprimido

---

25

Neurologia · Alucinações visuais e flutuação 9 anos depois do parkinsonismo: demência da doença de Parkinson, pela regra de 1 ano

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 74 anos começou com tremor de repouso na mão esquerda há 9 anos, depois lentidão e rigidez à esquerda, com resposta excelente à levodopa, hoje 200 mg 4 vezes ao dia, sem mudança de dose há 2 anos. Há 1 ano a esposa nota esquecimentos, lentidão para planejar tarefas e períodos de confusão que alternam com dias de lucidez. Há 6 meses vê pessoas desconhecidas na sala, sem medo. Há anos se debate e grita durante o sono. MoCA 17. Sem febre, sem infecção identificada, sódio e glicemia normais. RM de crânio com atrofia leve difusa, sem dilatação ventricular desproporcional. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

há 9 anos

Resolução. Alucinações visuais bem formadas, flutuação da cognição e distúrbio comportamental do sono REM são os critérios centrais da demência com corpos de Lewy, e são verdadeiros aqui. Mas as duas doenças compartilham a patologia de alfa-sinucleína e quase todos os achados; o que as separa, por convenção, é a cronologia. Se a demência começa antes do parkinsonismo ou até 1 ano depois dele, é demência com corpos de Lewy; se surge num parkinsonismo estabelecido há mais de 1 ano, é demência da doença de Parkinson. Este paciente teve tremor assimétrico com ótima resposta à levodopa por 8 anos antes do declínio cognitivo. Alzheimer começaria pela memória episódica, sem alucinações precoces, e a RM afasta hidrocefalia.

A) Demência da doença de Parkinson CORRETA

Correta. Demência que surge após mais de 1 ano de doença de Parkinson estabelecida é demência da doença de Parkinson.

B) Demência com corpos de Lewy ARMADILHA

Errada. Exigiria demência antes do parkinsonismo ou no primeiro ano dele; aqui a demência veio 8 anos depois.

C) Doença de Alzheimer

Errada. Começaria pela memória episódica, sem alucinações e flutuação precoces, e não explicaria o parkinsonismo responsivo à levodopa.

D) Hidrocefalia de pressão normal
Errada. Daria marcha magnética e incontinência com ventrículos desproporcionais, que a RM afastou.

Para levar. Demência com corpos de Lewy e demência da doença de Parkinson se separam pelo relógio: demência antes ou até 1 ano após o parkinsonismo é Lewy; depois de 1 ano de Parkinson estabelecido, é demência da doença de Parkinson.

McKeith IG et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 2017; Emre M et al. Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord 2007.

Revisa: S4 q12: rótulo contra discriminante na demência com corpos de Lewy (agora a cronologia contra a demência da doença de Parkinson)

26

Reumatologia · Nefrite lúpica com proliferação endocapilar em 70% dos glomérulos e depósitos subendoteliais: classe IV e indução com micofenolato e glicocorticoide

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 26 anos, com lúpus há 3 anos, apresenta edema de membros inferiores há 1 mês. PA 150 × 94 mmHg. Creatinina subiu de 1,1 para 1,6 mg/dL em 6 semanas; proteinúria 3,2 g/24h; hematúria dismórfica com cilindros hemáticos. C3 e C4 baixos, anti-DNA nativo 1:640. Biópsia renal: proliferação endocapilar em 70% dos glomérulos, com depósitos subendoteliais à microscopia eletrônica, crescentes celulares em 10% e índice de cronicidade de 1 de 12. Sem gestação e sem infecção ativa. A classe histológica e a indução mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

proliferação endocapilar em 70% dos glomérulos

Resolução. A classe III e a classe IV têm o mesmo tipo de lesão (proliferação endocapilar com depósitos subendoteliais), e o que as separa é a extensão: menos de 50% dos glomérulos é classe III, 50% ou mais é classe IV. Com 70%, é classe IV, ativa, com crescentes e cronicidade baixa, portanto com muito a ganhar com tratamento. As duas classes proliferativas, porém, pedem a mesma indução: glicocorticoide associado a micofenolato ou a ciclofosfamida em dose baixa, com possibilidade de terceira droga (belimumabe ou inibidor de calcineurina), além de hidroxicloroquina e bloqueio do eixo renina-angiotensina. Glicocorticoide isolado tem mais recidiva e evolução para doença renal crônica, e o bloqueio do eixo sozinho serve às classes I e II com proteinúria.

A) Classe IV / micofenolato e glicocorticoide CORRETA
Correta. Lesão proliferativa em 50% ou mais dos glomérulos é classe IV, induzida com micofenolato e glicocorticoide.

B) Classe V / tacrolimo isolado
Errada. A classe V é membranosa, com depósitos subepiteliais e sem proliferação endocapilar; tacrolimo isolado não é indução de doença proliferativa.

C) Classe III / glicocorticoide isolado ARMADILHA
Errada. É a armadilha: classe III seria com menos de 50% dos glomérulos, e mesmo nela o glicocorticoide isolado é insuficiente.

D) Classe IV / bloqueio do SRAA isolado
Errada. A classe está certa, mas bloqueio isolado do eixo é para nefrite não proliferativa; aqui subtrata uma doença grave.

Para levar. Nefrite lúpica proliferativa (classe III abaixo de 50% dos glomérulos, IV a partir de 50%) sempre se induz com glicocorticoide associado a micofenolato ou ciclofosfamida, nunca com corticoide isolado.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis; Fanouriakis A et al. EULAR recommendations for the management of SLE: 2023 update; Bajema IM et al. Revision of the ISN/RPS classification for lupus nephritis (2018).

Revisa: S2 q75 e S1 q91: porte decidido pela gravidade; agora a nefrite proliferativa que pede indução, o inverso da classe II

---

27 Emergência e UTI · Asma grave intubada com acidose respiratória e auto-PEEP alta: reduzir a frequência e aceitar hipercapnia

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 29 anos, com asma grave, foi intubada há 1 hora por exaustão. Recebe salbutamol, ipratrópio, metilprednisolona e sulfato de magnésio. Ventilação controlada a volume: volume corrente 450 mL (7 mL/kg de peso predito), frequência 26 irpm, fluxo inspiratório 60 L/min, PEEP 5 cmH2O, FiO2 0,4. Pressão de pico 52 cmH2O, pressão de platô 33 cmH2O; na pausa expiratória, PEEP total de 17 cmH2O. A curva de fluxo mostra que o fluxo expiratório não chega a zero antes do ciclo seguinte. PA 92 × 58 mmHg, FC 124 bpm, SpO2 95%. Gasometria: pH 7,16, PaCO2 78 mmHg, PaO2 96 mmHg, bicarbonato 27 mEq/L. Murmúrio diminuído e simétrico, traqueia centrada. O ajuste mais adequado do ventilador é:

O DADO QUE DECIDE

o fluxo expiratório não chega a zero antes do ciclo seguinte

Resolução. A acidose respiratória com PaCO2 de 78 mmHg é verdadeira e faz parecer lógico aumentar a ventilação minuto com mais frequência. Mas o problema é que o ar não sai: o fluxo expiratório não zera, a PEEP total é 12 cmH2O acima da programada e o platô passa de 30 cmH2O, o que define hiperinsuflação dinâmica, já com repercussão na pressão arterial. Mais frequência encurta o tempo expiratório e agrava o aprisionamento, a hipotensão e o risco de barotrauma. A estratégia é prolongar a expiração, sobretudo reduzindo a frequência (o maior determinante do tempo expiratório), aceitando a hipercapnia enquanto o pH se mantiver acima de cerca de 7,15 a 7,20 e a oxigenação estiver adequada. Reduzir o fluxo inspiratório alonga a inspiração e encurta a expiração, o contrário do que se quer.

A) Reduzir a frequência respiratória CORRETA
Correta. Hiperinsuflação dinâmica com platô alto: menos frequência para alongar a expiração, com hipercapnia permissiva.

B) Aumentar a frequência respiratória ARMADILHA
Errada. É a armadilha da acidose: encurta a expiração, aumenta a auto-PEEP e pode precipitar colapso circulatório.

C) Aumentar o volume corrente
Errada. Mais volume com platô de 33 cmH2O aumenta o aprisionamento e o risco de barotrauma.

D) Reduzir o fluxo inspiratório
Errada. Fluxo menor prolonga a inspiração e encurta o tempo expiratório; o certo seria fluxo mais alto.

Para levar. Na via aérea obstruída intubada, a acidose respiratória não se corrige com mais frequência: reduzir frequência e volume, alongar a expiração e aceitar hipercapnia.

GINA 2026; III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica e Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica AMIB/SBPT (2013); Leatherman J. Mechanical ventilation for severe asthma. Chest 2015.

Revisa: S4 q34: hiperinsuflação dinâmica após intubar a via aérea obstruída; agora pelo ajuste do ventilador na asma

---

28 Infectologia · Carbapenemase de classe A (KPC) em paciente vindo de hospital com surto de NDM: ceftazidima-avibactam isolada

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 66 anos, transferido há 10 dias de um hospital que comunicou surto de Klebsiella pneumoniae produtora de NDM no mesmo setor em que ele esteve internado, apresenta febre e hipotensão no 3º dia de cateter venoso central. Duas hemoculturas crescem Klebsiella pneumoniae resistente a meropenem, cefepima e piperacilina-tazobactam. No laboratório, o teste fenotípico mostra inibição pelo ácido fenilborônico presente e sinergia com EDTA ausente; o teste imunocromatográfico é reagente para KPC e não reagente para NDM, OXA-48, VIM e IMP. Sensível à ceftazidima-avibactam e ao meropenem-vaborbactam; resistente ao aztreonam. Creatinina 1,1 mg/dL. O cateter já foi retirado. A terapia mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

inibição pelo ácido fenilborônico presente e sinergia com EDTA ausente

Resolução. A internação num setor com surto de NDM é verdadeira e puxa para metalobetalactamase, cujo tratamento é a associação de aztreonam com ceftazidima-avibactam. Mas o isolado deste paciente conta outra história: inibição pelo ácido fenilborônico indica serinocarbapenemase de classe A, a ausência de sinergia com EDTA afasta metaloenzima, e o teste imunocromatográfico confirma KPC sem NDM. O avibactam inibe KPC, de modo que a ceftazidima-avibactam isolada é ativa e é primeira linha, ao lado de meropenem-vaborbactam. O aztreonam só é acrescentado porque as metaloenzimas o poupam e o avibactam protege contra as outras betalactamases; com KPC e resistência ao aztreonam, a associação não traz ganho. Polimixinas ficam como alternativa de toxicidade alta e eficácia inferior.

A) Polimixina B com amicacina
Errada. Esquema de resgate para isolado resistente a todos os novos betalactâmicos, o que não é o caso.

B) Polimixina B com meropenem
Errada. Associação usada antes dos novos inibidores, com mais nefrotoxicidade e mortalidade; não é mais primeira linha quando há sensibilidade aos novos betalactâmicos.

C) Ceftazidima-avibactam isolada CORRETA
Correta. KPC (classe A, inibida pelo ácido fenilborônico) é inibida pelo avibactam; o novo betalactâmico isolado é a escolha.

D) Aztreonam com ceftazidima-avibactam ARMADILHA
Errada. É a armadilha do surto: seria a escolha para NDM ou outra metalobetalactamase, afastada pela ausência de sinergia com EDTA e pelo teste negativo.

Para levar. Ácido fenilborônico positivo é classe A (KPC): ceftazidima-avibactam ou meropenem-vaborbactam isolados. EDTA positivo é metaloenzima (NDM): aztreonam associado à ceftazidima-avibactam. Quem decide é o isolado, e não o surto.

IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2024; Nota Técnica ANVISA GVIMS/GGTES sobre detecção de carbapenemases (2021).

Revisa: S1 q73: classe da carbapenemase pelo teste fenotípico define o esquema; aqui o rótulo do surto puxa para NDM

---

29 Endocrinologia · Hiperparatireoidismo primário assintomático em homem de 46 anos sem outro critério: a idade abaixo de 50 indica a paratireoidectomia

Limiar **Gabarito B**

Homem de 46 anos, assintomático, teve hipercalcemia detectada em exame de rotina. Cálcio total 10,9 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,3 g/dL, PTH 104 pg/mL (15 a 65), fósforo 2,6 mg/dL, 25-hidroxivitamina D 38 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL (TFG estimada 98 mL/min/1,73 m²), calciúria de 24 horas 210 mg. Ultrassonografia renal sem cálculos ou nefrocalcinose. Densitometria: T-escore de -1,9 na coluna lombar, -1,6 no colo do fêmur e -1,7 no terço distal do rádio; avaliação de fratura vertebral sem fraturas. Não usa lítio nem tiazídico. Deseja evitar cirurgia se possível. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Homem de 46 anos

Resolução. O paciente não tem sintomas, o cálcio está menos de 1 mg/dL acima do limite, a densitometria não atinge osteoporose, a função renal é normal, a calciúria está abaixo de 250 mg em homem e não há cálculos. Quem confere só esses itens conclui pelo seguimento. Mas o critério de idade vale sozinho: abaixo de 50 anos o hiperparatireoidismo primário assintomático tem indicação cirúrgica, porque a chance de progressão ao longo de décadas é alta e a cirurgia é curativa. A paratireoidectomia, com localização pré-operatória, é a conduta. Cinacalcete reduz o cálcio sem melhorar a massa óssea, e o alendronato protege o osso sem tratar a doença; ambos ficam para quem não pode ou não aceita operar depois de esclarecido.

A) Alendronato e seguimento
Errada. O bisfosfonato entra na osteoporose de quem não opera; aqui a densitometria não é de osteoporose e a doença tem tratamento curativo.

B) Paratireoidectomia CORRETA
Correta. Idade abaixo de 50 anos indica cirurgia no hiperparatireoidismo primário, mesmo assintomático.

C) Cinacalcete e seguimento
Errada. Seria a opção para quem tem indicação mas não pode operar; não cura e não melhora a densidade óssea.

D) Seguimento anual com cálcio e densitometria ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o seguimento serve ao assintomático sem nenhum critério, e idade abaixo de 50 anos é um critério.

Para levar. Hiperparatireoidismo primário assintomático vai à cirurgia com qualquer um: cálcio 1 mg/dL acima do limite, T-escore até -2,5 em qualquer sítio (inclusive rádio) ou fratura vertebral, TFG abaixo de 60, calciúria acima de 250 a 300 mg ou litíase, ou idade abaixo de 50 anos.

Bilezikian JP et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. J Bone Miner Res 2022.

Revisa: S2 q33 e S1 q10: critério cirúrgico do hiperparatireoidismo; agora o critério que sobra é a idade

---

30

Gastroenterologia e hepatologia · Insuficiência hepática aguda com hemólise após antibiótico e ceruloplasmina normal: doença de Wilson pela fosfatase alcalina baixa

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Mulher de 19 anos, previamente hígida, apresenta icterícia progressiva há 10 dias; 2 semanas antes usou amoxicilina com clavulanato por 7 dias para sinusite. Está sonolenta, com flapping, afebril, PA 108/66 mmHg. Exames: hemoglobina 8,1 g/dL, reticulócitos 9%, Coombs direto negativo, LDH 980 U/L, AST 410 U/L, ALT 160 U/L, bilirrubina total 28 mg/dL (indireta 9), fosfatase alcalina 18 U/L (40 a 130), INR 3,4, creatinina 1,9 mg/dL. Ceruloplasmina 24 mg/dL (20 a 60), FAN 1:80 padrão pontilhado fino, IgG 1.500 mg/dL, sorologias para hepatites A, B, C e E negativas. O plantonista não viu anéis corneanos à lanterna. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

fosfatase alcalina 18 U/L (40 a 130)

Resolução. A exposição recente a amoxicilina-clavulanato é verdadeira e é a causa medicamentosa mais comum de lesão hepática, mas ela provoca padrão colestático ou misto, com fosfatase alcalina alta. Aqui a fosfatase está abaixo da referência, a relação fosfatase/bilirrubina é menor que 4 e a relação AST/ALT é maior que 2,2: combinação que identifica a forma fulminante da doença de Wilson com alta acurácia, junto com a hemólise Coombs negativo causada pela liberação de cobre. A ceruloplasmina normal não afasta, porque é reagente de fase aguda e cai na insuficiência hepática de qualquer causa, perdendo valor nos dois sentidos; anéis de Kayser-Fleischer exigem lâmpada de fenda e podem faltar. A forma fulminante tem indicação de transplante de urgência.

A) Hepatite herpética disseminada
Errada. Herpes disseminado dá transaminases muito altas, febre e pouca icterícia, sem fosfatase baixa.

B) Hepatite autoimune fulminante
Errada. FAN em título baixo é inespecífico, a IgG é normal e a hepatite autoimune não explica fosfatase baixa e hemólise.

C) Hepatite por amoxicilina-clavulanato ARMADILHA
Errada. É o rótulo verdadeiro: a lesão por amoxicilina-clavulanato é colestática ou mista, com fosfatase alta, e não cursa com hemólise.

D) Doença de Wilson CORRETA
Correta. Fosfatase alcalina baixa, relação fosfatase/bilirrubina menor que 4, AST/ALT maior que 2,2 e hemólise Coombs negativo.

Para levar. Insuficiência hepática aguda em jovem com hemólise Coombs negativo e fosfatase alcalina baixa é doença de Wilson; ceruloplasmina normal não exclui.

AASLD Practice Guidance on Wilson disease (2022); EASL-ERN Clinical Practice Guidelines on Wilson's disease (2025).

Revisa: S3 q29: Wilson reconhecido pela fosfatase alcalina baixa, agora contra o rótulo de hepatite medicamentosa e com ceruloplasmina normal

---

31 Nefrologia · Hiponatremia na meningite tuberculosa com hematócrito e ureia subindo e balanço negativo: perda cerebral de sal, salina e fludrocortisona

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 34 anos está internado há 10 dias por meningite tuberculosa em tratamento com esquema básico e dexametasona. O sódio caiu de 138 para 124 mEq/L em 4 dias, com diurese de 4,2 litros por dia e balanço hídrico negativo. PA 112/70 mmHg deitado e 92/58 mmHg sentado, FC 112 bpm, mucosas secas. No mesmo período, o hematócrito subiu de 38% para 44% e a ureia de 30 para 52 mg/dL. Sódio urinário 168 mEq/L, osmolalidade urinária 520 mOsm/kg, ácido úrico sérico 2,1 mg/dL, TSH e cortisol normais. A conduta mais adequada para o sódio é:

O DADO QUE DECIDE

o hematócrito subiu de 38% para 44% e a ureia de 30 para 52 mg/dL

Resolução. Meningite tuberculosa é causa frequente de SIADH, e sódio urinário alto com urina concentrada e ácido úrico baixo são comuns às duas síndromes, o que puxa para restrição hídrica. O que separa é o volume extracelular ao longo dos dias: na SIADH o paciente está euvolêmico ou levemente expandido, e o hematócrito e a ureia tendem a cair; aqui, com poliúria e balanço negativo, o hematócrito e a ureia sobem, há hipotensão postural e taquicardia. Isso é perda cerebral de sal, e restringir água nessa situação agrava a hipovolemia e, em doença do sistema nervoso central, o risco de isquemia. Repõe-se o volume e o sódio com salina (isotônica ou hipertônica conforme a gravidade), e a fludrocortisona reduz a natriurese quando a perda é persistente.

A) Salina e fludrocortisona CORRETA
Correta. Hipovolemia documentada (hematócrito e ureia subindo, hipotensão postural) com natriurese: perda cerebral de sal, salina e fludrocortisona.

B) Restrição hídrica a 800 mL/dia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta da SIADH euvolêmica; na perda de sal piora a hipovolemia e a perfusão cerebral.

C) Tolvaptana oral
Errada. Vaptanos aumentam a perda de água livre e agravam a contração de volume; não se usam na hipovolemia.

D) Ureia oral
Errada. A ureia oral é alternativa na SIADH crônica, não na perda de sal com hipovolemia.

Para levar. Na hiponatremia com natriurese em doença do sistema nervoso central, quem decide é o volume: hematócrito e ureia subindo com hipotensão postural é perda cerebral de sal e pede salina, nunca restrição.

Spasovski G et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014; Cerdà-Esteve M et al. Cerebral salt wasting syndrome: review. Eur J Intern Med 2008.

Revisa: S1 q50: perda cerebral de sal tratada com salina, agora na meningite tuberculosa e pela cronologia do hematócrito

---

32 Cardiologia · Choque obstrutivo no paciente oncológico com TVP conhecida: o derrame com VD pequeno pede pericardiocentese, e não trombólise

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 61 anos com adenocarcinoma de pulmão estádio IV teve trombose venosa profunda da veia poplítea esquerda há 10 dias e usa enoxaparina 1 mg/kg de 12/12 horas. Há 4 dias tem dispneia progressiva e hoje está sonolento. PA 84 × 62 mmHg, FC 124 bpm, FR 28 irpm, SpO2 93% em ar ambiente; jugulares distendidas, pulmões limpos e bulhas abafadas. A pressão sistólica cai 18 mmHg na inspiração. ECG: taquicardia sinusal com baixa voltagem e alternância do QRS. D-dímero 4.800 ng/mL. Ecocardiograma à beira do leito: derrame pericárdico circunferencial de 2,4 cm, ventrículo direito de dimensões reduzidas e veia cava inferior de 2,3 cm sem variação respiratória. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

ventrículo direito de dimensões reduzidas

Resolução. Câncer ativo, trombose venosa recente, D-dímero alto, taquicardia, hipoxemia e jugulares distendidas formam um quadro de TEP maciço, e o rótulo é verdadeiro: o paciente tem trombose. Mas o pulso paradoxal, as bulhas abafadas e a alternância elétrica apontam tamponamento, e o eco separa as duas causas de choque obstrutivo pelo ventrículo direito: no TEP maciço ele é dilatado, com septo desviado; no tamponamento ele é pequeno, comprimido pelo derrame. A veia cava dilatada e fixa confirma a pressão venosa alta. A conduta é pericardiocentese guiada por eco, com análise citológica do líquido (provável derrame neoplásico). Trombólise num derrame volumoso pode transformá-lo em hemopericárdio; diurético reduz a pré-carga de que o coração comprimido depende; e ventilação com pressão positiva derruba ainda mais o retorno venoso e pode precipitar a parada.

A) Furosemida intravenosa
Errada. Jugulares distendidas não são congestão por sobrecarga; tirar volume de quem depende da pré-carga agrava o choque.

B) Pericardiocentese de urgência CORRETA
Correta. Tamponamento com instabilidade exige drenagem imediata, e o eco guia a punção.

C) Trombólise com alteplase ARMADILHA
Errada. Seria a conduta no TEP de alto risco, com VD dilatado; aqui o VD é pequeno e o choque é pericárdico, e o trombolítico pode causar hemopericárdio.

D) Intubação e noradrenalina
Errada. A pressão positiva reduz o retorno venoso e pode precipitar parada no tamponamento; drena-se antes de intubar.

Para levar. No choque obstrutivo com jugulares distendidas, o ventrículo direito separa as causas: dilatado é TEP, pequeno e comprimido por derrame é tamponamento, que se drena sem diurético e, se possível, antes de pressão positiva.

2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases; 2019 ESC Guidelines for acute pulmonary embolism; Diretriz Brasileira de Miocardites e Pericardites, SBC 2022.

Revisa: S1 q84: tamponamento contra TEP no paciente oncológico (agora pela conduta e pelo VD)

---

33 Hematologia · Cateter venoso central guiado por ultrassom com 24.000 plaquetas na quimioterapia: sem transfusão profilática

Limiar **Gabarito A**

Mulher de 41 anos, no décimo dia de indução para leucemia mieloide aguda, precisa de um cateter venoso central não tunelizado em veia jugular interna para nutrição e antibióticos, porque o cateter anterior foi retirado por trombose. Sem sangramento cutâneo ou mucoso, afebril, PA 118/72 mmHg. Plaquetas 24.000/mm³, hemoglobina 8,4 g/dL, INR 1,2, TTPa normal, fibrinogênio 340 mg/dL. Um intensivista experiente fará a punção guiada por ultrassom. O residente propõe transfundir plaquetas até 50.000/mm³ antes do procedimento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Plaquetas 24.000/mm³

Resolução. A plaquetopenia da quimioterapia assusta, e 50.000 é um limiar que o aluno conhece para procedimentos. Mas os limiares variam com o porte e o sítio: 100.000 para neurocirurgia, cerca de 50.000 para punção lombar e cirurgia de maior porte, e 20.000 para cateter venoso central não tunelizado em sítio compressível, com punção guiada por ultrassom. Ensaios recentes mostraram que, mesmo entre 10.000 e 50.000, a transfusão profilática reduz pouco o sangramento e expõe a reações; a recomendação é transfundir abaixo de 10.000 a 20.000 conforme a diretriz. Com 24.000, coagulograma normal e ultrassom, o cateter é inserido sem transfusão.

A) Inserir guiado por ultrassom sem transfundir CORRETA

Correta. Acima de 20.000, com coagulograma normal e punção guiada por ultrassom em sítio compressível, não há indicação de transfusão profilática.

B) Transfundir uma dose de plaquetas antes

Errada. Seria indicada abaixo de 10.000 a 20.000 plaquetas; com 24.000 só aumenta exposição e consumo de hemocomponente.

C) Transfundir até plaquetas acima de 50.000 ARMADILHA

Errada. É a armadilha do limiar: 50.000 é para procedimento de maior porte ou punção lombar, não para cateter guiado em jugular.

D) Adiar até recuperação espontânea das plaquetas

Errada. Adiar priva a paciente de acesso necessário; a recuperação medular leva semanas.

Para levar. Limiares de plaquetas por procedimento: cateter central guiado por ultrassom, 20.000; punção lombar, 40.000 a 50.000; cirurgia maior, 50.000; neurocirurgia, 100.000.

AABB International Guidelines for Platelet Transfusion (Metcalf RA et al., 2025); BSH Guidelines for the use of platelet transfusions (2017); van Baarle FLF et al. PACER trial, NEJM 2023.

Revisa: S2 q32: limiar de plaquetas pelo porte do procedimento, agora no sentido oposto (exagero no estável)

---

34 Neurologia · Primeira crise tônico-clônica após privação de sono, com mioclonias matinais prévias e EEG alterado: é epilepsia e se trata

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 22 anos, estudante de Medicina, teve crise tônico-clônica generalizada às 7 horas da manhã, após um plantão de 30 horas sem dormir e duas latas de cerveja na noite anterior. Nunca teve crise desse tipo. Perguntado, conta que há cerca de 1 ano tem abalos bruscos nos braços pela manhã, que já o fizeram derrubar a xícara do café, sempre nos dias em que dorme pouco. Exame neurológico normal. Glicemia, sódio, cálcio e magnésio normais; toxicológico negativo. RM de crânio normal. EEG: complexos de poliespícula-onda generalizados a 4 a 6 Hz, aumentados pela fotoestimulação. A classificação do evento e a conduta quanto à droga anticrise são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

abalos bruscos nos braços pela manhã

Resolução. A privação de sono e a cerveja são verdadeiras e oferecem o rótulo de crise provocada, que não pediria anticrise. Mas crise sintomática aguda é a que ocorre em estreita relação com uma agressão aguda ao cérebro (distúrbio metabólico, toxina, abstinência, infecção, trauma, AVC): privação de sono e álcool em pequena quantidade são fatores desencadeantes em quem já tem limiar baixo, e não causas. A história revela mioclonias matinais há 1 ano, que são crises, e o EEG mostra poliespícula-onda generalizada com fotossensibilidade: é epilepsia mioclônica juvenil, com mais de uma crise e alto risco de recorrência. Pela definição da ILAE já é epilepsia, e o tratamento está indicado, junto com higiene do sono; a epilepsia mioclônica juvenil tende a exigir tratamento prolongado. Repetir o EEG não acrescenta nada a um exame já diagnóstico.

A) Crise provocada / sem anticrise ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na crise sintomática aguda por causa metabólica ou tóxica; privação de sono é desencadeante, e as mioclonias prévias já são crises.

B) Epilepsia / iniciar anticrise CORRETA
Correta. Mioclonias prévias e EEG com poliespícula-onda generalizada definem epilepsia, que se trata.

C) Crise provocada / anticrise por 6 meses
Errada. Combina dois erros: chama de provocada uma epilepsia e propõe prazo curto que não se aplica a nenhuma das duas situações.

D) Epilepsia / repetir EEG antes de tratar
Errada. Repetir EEG seria útil se o primeiro fosse normal; este já é diagnóstico.

Para levar. Privação de sono e álcool em pouca quantidade desencadeiam crises em quem tem epilepsia, mas não fazem delas crises provocadas; pergunte sempre por mioclonias matinais e ausências antes de rotular a primeira crise.

Fisher RS et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia 2014; Beghi E et al. Recommendation for a definition of acute symptomatic seizure. Epilepsia 2010; ILAE 2022 definitions of idiopathic generalized epilepsy syndromes.

Revisa: S4 q30 e S2 q7: crise provocada contra epilepsia, e quando a anticrise é indicada (agora no sentido de tratar)

---

35 Reumatologia · Doença de Still do adulto: a fração glicosilada da ferritina baixa é mais específica que a ferritina total

Qualificador **Gabarito A**

No adulto com febre diária acima de 39 °C, exantema evanescente cor de salmão que aparece com a febre, artralgias, odinofagia e ferritina de 9.800 ng/mL, sem infecção ou neoplasia identificadas, o achado laboratorial de maior especificidade para doença de Still do adulto é:

O DADO QUE DECIDE

de maior especificidade

Resolução. A ferritina muito alta é o exame mais lembrado na doença de Still e entra nos critérios de Fautrel, mas ela sobe também em infecções, linfomas, hepatopatias e ativação macrofágica, e por isso é sensível e pouco específica. A ferritina normalmente circula glicosilada em mais de 50%; na doença de Still, a saturação do mecanismo de glicosilação faz a fração glicosilada cair abaixo de 20%, e essa queda, associada à ferritina alta, é o achado mais específico. A leucocitose neutrofílica e a negatividade de fator reumatoide e FAN integram os critérios de Yamaguchi, mas ocorrem em muitas outras doenças febris. O comando pede especificidade, e não sensibilidade nem frequência.

A) Ferritina glicosilada abaixo de 20% CORRETA

Correta. Fração glicosilada abaixo de 20% é o marcador laboratorial mais específico, sobretudo com ferritina alta.

B) Ferritina acima de cinco vezes o normal ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a ferritina alta é sensível e frequente, mas aparece em infecção, linfoma e ativação macrofágica.

C) Leucocitose neutrofílica acima de 15.000

Errada. Leucocitose neutrofílica é frequente e entra em Yamaguchi, mas é comum em infecções bacterianas.

D) Fator reumatoide e FAN negativos

Errada. A negatividade é critério menor de Yamaguchi e não diferencia o Still de infecção ou linfoma.

Para levar. Doença de Still: ferritina alta é sensível; a fração glicosilada abaixo de 20% é o dado mais específico. O diagnóstico ainda exige excluir infecção, neoplasia e outras doenças sistêmicas.

Fautrel B et al. Proposal for a new set of classification criteria for adult-onset Still disease. Medicine 2002; Fautrel B et al. EULAR/PReS recommendations for the diagnosis and management of Still's disease (2024).

Revisa: UERJ pouco explorado: doença de Still, com o qualificador de especificidade

---

36 Infectologia · Endocardite enterocócica mitral com AVC isquêmico sem sangramento no 4º dia de antibiótico: cirurgia sem adiar

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 71 anos está internado com endocardite de valva mitral nativa. As hemoculturas cresceram Enterococcus faecalis sensível à ampicilina, com resistência de alto nível à gentamicina. O ecocardiograma transesofágico mostra vegetação móvel de 14 mm no folheto anterior, insuficiência mitral moderada, sem abscesso. No 4º dia de antibiótico, ainda febril, apresenta afasia de expressão e paresia discreta da mão direita, com NIHSS 3, plenamente consciente. TC de crânio: hipodensidade cortical frontal esquerda pequena, sem transformação hemorrágica; angiotomografia sem aneurisma micótico. Função renal normal, sem insuficiência cardíaca. A equipe cirúrgica considera o risco operatório aceitável. Esquema antimicrobiano e momento da cirurgia valvar, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

sem transformação hemorrágica

Resolução. O AVC é verdadeiro e puxa para adiar a cirurgia por medo de converter o infarto em hemorragia durante a circulação extracorpórea, como se faz no AVC hemorrágico. Mas um evento embólico em vigência de antibiótico com vegetação acima de 10 mm é indicação de cirurgia precoce para evitar novas embolias, e o AVC isquêmico pequeno, sem sangramento, sem aneurisma micótico e sem coma não deve atrasá-la. Quanto ao antimicrobiano, Enterococcus faecalis sensível à ampicilina com resistência de alto nível à gentamicina não se beneficia do aminoglicosídeo, e a dupla de betalactâmicos, que satura proteínas ligadoras de penicilina diferentes, é a escolha. A vancomicina fica para o enterococo resistente à ampicilina ou para alergia grave à penicilina.

A) Vancomicina e gentamicina / sem adiar
Errada. Acerta o momento, mas a gentamicina é inútil com resistência de alto nível e a vancomicina não é necessária com sensibilidade à ampicilina.

B) Ampicilina e ceftriaxona / após 4 semanas ARMADILHA
Errada. Acerta o antimicrobiano, mas adia a cirurgia: a espera de 4 semanas vale para AVC hemorrágico ou grande, e não para o pequeno isquêmico sem sangramento.

C) Vancomicina e gentamicina / após 4 semanas
Errada. Erra as duas decisões: aminoglicosídeo sem sinergia e adiamento sem indicação.

D) Ampicilina e ceftriaxona / sem adiar CORRETA
Correta. Dupla de betalactâmicos para Enterococcus faecalis sensível à ampicilina e cirurgia sem adiar após embolia sob antibiótico com AVC isquêmico sem sangramento.

Para levar. Embolia em vigência de antibiótico com vegetação acima de 10 mm pede cirurgia precoce; AVC isquêmico sem hemorragia e sem coma não adia a operação.

2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis; AATS Expert Consensus Guidelines on Surgical Treatment of Infective Endocarditis (2017).

Revisa: S3 q47: embolia durante o tratamento com vegetação grande indica cirurgia precoce, e o AVC isquêmico não a adia

---

37

Cronologia **Gabarito D**

Pneumologia · Pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica por umidificador doméstico: afastar o antígeno e reavaliar antes de corticoide ou biópsia

Mulher de 44 anos, professora, não tabagista, sem animais em casa, refere há 7 meses tosse seca, dispneia aos esforços moderados, febre baixa e mal-estar que aparecem à noite e pela manhã. Comprou um umidificador ultrassônico para o quarto há 8 meses, que limpa a cada 15 dias. Os sintomas melhoraram durante 10 dias de viagem ao litoral e pioraram dois dias após voltar. Ausculta com estertores finos esparsos e grasnidos. SpO2 94% em repouso, 91% ao caminhar. Espirometria: CVF 76% do previsto, VEF1/CVF 0,84; DLCO 66%. TC de alta resolução: nódulos centrolobulares em vidro fosco difusos e mosaico com aprisionamento expiratório, sem reticulado, sem bronquiectasias de tração e sem faveolamento. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

melhoraram durante 10 dias de viagem ao litoral e pioraram dois dias após voltar

Resolução. A dispneia com dessaturação ao esforço e a DLCO reduzida parecem pedir corticoide já. Mas a cronologia entrega o mecanismo: os sintomas começaram após a compra do umidificador, melhoraram longe de casa e voltaram dois dias depois do retorno, num padrão tomográfico de nódulos centrolobulares e mosaico com aprisionamento, sem fibrose. Essa é a pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica, e a medida que mais altera o prognóstico é afastar o antígeno, que costuma bastar para a melhora. O corticoide fica para doença grave ou que não melhora após a remoção da exposição, e a biópsia só se justifica quando a TC e a exposição não fecham o diagnóstico. Imunossupressor poupador de corticoide pertence à forma fibrótica ou refratária.

A) Prednisona 0,5 mg/kg por 3 meses ARMADILHA
Errada. É a armadilha: corticoide é reservado à forma grave ou que não melhora após o afastamento do antígeno.

B) Criobiópsia transbrônquica
Errada. Seria o passo quando TC e exposição são discordantes; aqui o padrão e a cronologia fecham o diagnóstico.

C) Micofenolato associado a prednisona
Errada. Poupador de corticoide usado na forma fibrótica progressiva ou refratária, nada disso presente.

D) Retirar o umidificador e reavaliar CORRETA
Correta. Exposição identificada com melhora ao se afastar dela e TC sem fibrose: remover o antígeno e reavaliar.

Para levar. Na pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica com antígeno identificado, o primeiro tratamento é afastar a exposição e reavaliar; corticoide e biópsia vêm depois, se preciso.

ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis (Raghu et al., 2020); Diretrizes de Doenças Pulmonares Intersticiais da SBPT (2012).

Revisa: S3 q74: pneumonite de hipersensibilidade não fibrótica se trata afastando o antígeno, antes de corticoide ou biópsia

38

Endocrinologia · Hipercalcemia com hipofosfatemia, hipercalciúria e PTH suprimido em usuária de biotina em dose alta: repetir o PTH sem o suplemento

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 57 anos com dois episódios de cólica renal por cálculo de oxalato de cálcio nos últimos 3 anos. Há 4 meses toma uma cápsula manipulada de 10 mg ao dia, prescrita pela dermatologista para unhas quebradiças e queda de cabelo. Assintomática no momento, sem emagrecimento, sem tosse, sem dor óssea. Cálcio total 11,3 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,1 g/dL, fósforo 2,2 mg/dL (2,5 a 4,5), PTH 9 pg/mL (15 a 65, imunoensaio quimioluminescente), 25-hidroxivitamina D 34 ng/mL, PTHrP indetectável, eletroforese de proteínas normal, creatinina 0,8 mg/dL, calciúria de 24 horas 340 mg. Radiografia de tórax normal. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

uma cápsula manipulada de 10 mg ao dia

Resolução. Hipercalcemia com PTH abaixo do normal costuma ser lida como independente de PTH, e o passo seguinte seria procurar produção de calcitriol por granuloma ou linfoma. Mas o resto do quadro é de hiperparatireoidismo: litíase recorrente, fósforo baixo (o PTH reduz a reabsorção tubular de fosfato) e calciúria alta, sem neoplasia nem granulomatose aparentes. O suplemento de 10 mg ao dia para cabelo e unhas é biotina em dose cerca de 300 vezes a necessidade diária, e ela interfere nos imunoensaios baseados em estreptavidina e biotina: nos ensaios em sanduíche, como o do PTH e o do TSH, o resultado sai falsamente baixo. O exame que resolve é repetir o PTH depois de suspender a biotina por pelo menos 48 a 72 horas, ou por outro método; espera-se PTH elevado ou inapropriadamente normal.

A) PTH após suspender o suplemento CORRETA
Correta. Biotina em dose alta reduz falsamente o PTH no imunoensaio em sanduíche; suspender e repetir desfaz o artefato.

B) Cintilografia óssea de corpo inteiro
Errada. Procuraria metástases ósseas, sem suporte clínico, com PTHrP indetectável e eletroforese normal.

C) TC de tórax, abdome e pelve
Errada. Rastreio de neoplasia oculta antes de afastar um artefato de laboratório é exagero de porte.

D) 1,25-di-hidroxivitamina D sérica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o calcitriol seria o passo na hipercalcemia com PTH realmente suprimido, como em sarcoidose e linfoma, que costumam ter fósforo normal ou alto.

Para levar. Biotina em dose alta falseia imunoensaios: ensaios em sanduíche (PTH, TSH, troponina) saem falsamente baixos e os competitivos (T4 livre, T3) falsamente altos. Suspenda por 48 a 72 horas e repita.

FDA Safety Communication: biotin interference with laboratory tests (2017, atualizada 2019); Bilezikian JP et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Fifth International Workshop. J Bone Miner Res 2022.

Revisa: S2 q12: biotina falseando imunoensaio; agora no PTH, que cai em vez de subir

---

39

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Nefrologia · PTH subindo na DRC estágio 4 com 25-hidroxivitamina D baixa: colecalciferol, e não calcitriol

Mulher de 66 anos, com doença renal crônica estágio 4 por nefropatia diabética (TFGe de 22 mL/min/1,73 m²), sem diálise, comparece à consulta trimestral. Sai pouco de casa e usa roupas que cobrem quase todo o corpo. PTH de 190 pg/mL há 6 meses e de 260 pg/mL agora (referência 15 a 65), cálcio 9,0 mg/dL, fósforo 4,6 mg/dL, fosfatase alcalina 140 U/L (até 120), 25-hidroxivitamina D de 13 ng/mL, bicarbonato 23 mEq/L. Já segue orientação de dieta com restrição de fósforo. O residente sugere iniciar a forma ativa da vitamina D, porque o rim doente não faz a hidroxilação. A conduta mais adequada para o hiperparatireoidismo neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

25-hidroxivitamina D de 13 ng/mL

Resolução. O argumento do residente é verdadeiro (a 1-alfa-hidroxilação renal cai na DRC) e leva ao calcitriol. A diretriz, porém, manda tratar primeiro os fatores modificáveis do PTH em elevação na DRC não dialítica: fósforo alto, cálcio baixo, ingestão de fósforo e deficiência de 25-hidroxivitamina D. Com 25-hidroxivitamina D de 13 ng/mL, a reposição com colecalciferol fornece substrato e corrige parte do hiperparatireoidismo secundário. Calcitriol e análogos não são recomendados de rotina na DRC 3a a 5 sem diálise, porque aumentam hipercalcemia e hiperfosfatemia sem benefício clínico; ficam para hiperparatireoidismo grave e progressivo após corrigir os fatores modificáveis. Cinacalcete não tem indicação fora da diálise.

A) Paricalcitol oral
Errada. Paricalcitol, como o calcitriol, fica reservado ao hiperparatireoidismo grave e progressivo, com risco de hipercalcemia.

B) Calcitriol oral ARMADILHA
Errada. É a armadilha do raciocínio fisiológico: a KDIGO não recomenda calcitriol de rotina na DRC não dialítica.

C) Cinacalcete oral
Errada. O cinacalcete é aprovado no hiperparatireoidismo secundário em diálise, não na DRC estágio 4.

D) Colecalciferol oral CORRETA
Correta. PTH em elevação com 25-hidroxivitamina D baixa: repor vitamina D nativa antes de qualquer forma ativa.

Para levar. PTH subindo na DRC sem diálise: corrigir fósforo, cálcio e deficiência de 25-hidroxivitamina D com colecalciferol; calcitriol só para hiperparatireoidismo grave e progressivo.

KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for CKD-MBD; SBN, Diretrizes de DMO-DRC (2021).

Revisa: S4 q7: a 25-hidroxivitamina D vem antes da vitamina D ativa na DRC 4, agora pela conduta

---

40

Cardiologia · Dupla lesão mitral reumática com sopro sistólico intenso: B1 hiperfonética e ausência de B3 indicam estenose predominante

Negativo no meio | Gabarito D

Mulher de 33 anos teve febre reumática aos 9 anos e abandonou a profilaxia na adolescência. Há 8 meses tem dispneia aos médios esforços e dois episódios de palpitação. Exame: PA 106 × 70 mmHg, FC 92 bpm, ritmo regular, ictus no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular, não desviado, e impulsão paraesternal esquerda. Ausculta: B1 hiperfonética, estalido de abertura logo após B2, ruflar diastólico apical com reforço pré-sistólico e

sopro holossistólico apical 3+/6 irradiado para a axila; sem terceira bulha. Componente pulmonar de B2 aumentado. ECG: ritmo sinusal, onda P bífida de 140 ms em DII e eixo do QRS em +100 graus. A lesão predominante é:

O DADO QUE DECIDE

B1 hiperfonética

Resolução. O sopro holossistólico de 3+/6 irradiado para a axila é real e impressiona, e quem mede gravidade pela intensidade do sopro marca insuficiência predominante. Mas, na dupla lesão mitral, o que separa a lesão dominante são os sinais de volume do ventrículo esquerdo e a mobilidade da valva. B1 hiperfonética e estalido de abertura exigem folhetos ainda móveis e átrio com pressão alta, próprios da estenose; a ausência de B3 é importante, porque a terceira bulha exige enchimento rápido do ventrículo esquerdo, impossível com estenose significativa, e indica insuficiência dominante quando presente. O ictus não desviado mostra ventrículo esquerdo sem sobrecarga de volume, e o eixo à direita com P bífida indica sobrecarga do átrio esquerdo e do ventrículo direito. Estenose predominante tem implicação prática: a valvoplastia por balão depende de a insuficiência associada não ser mais que leve, o que o eco vai quantificar.

A) Lesões mitrais equilibradas
Errada. Equilíbrio exigiria sinais das duas sobrecargas, como ictus desviado com B1 hiperfonética; aqui só há os da estenose.

B) Estenose aórtica associada
Errada. Não há sopro ejetivo em foco aórtico nem sobrecarga do ventrículo esquerdo; o sopro sistólico é apical e irradia para a axila.

C) Insuficiência mitral predominante ARMADILHA
Errada. Indicaria B1 hipofonética, B3 e ictus desviado; a intensidade do sopro não mede a gravidade.

D) Estenose mitral predominante CORRETA
Correta. B1 hiperfonética, estalido, ausência de B3 e ictus no lugar indicam estenose dominante.

Para levar. Na dupla lesão mitral, a intensidade do sopro não decide: B1 hiperfonética, estalido e ausência de B3 apontam estenose predominante; B1 abafada, B3 e ictus desviado apontam insuficiência predominante.

Diretriz Brasileira de Valvopatias, SBC 2020; 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease.

Revisa: S3 dupla lesão mitral: qual lesão predomina pela semiologia (agora a estenose, com sopro sistólico alto como isca)

---

41 Gastroenterologia e hepatologia · HDA varicosa com Child-Pugh de 14 pontos: TIPS preemptivo fútil, terapia padrão

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 58 anos, com cirrose alcoólica e etilismo mantido até a internação, chega com hematêmese e melena. Recebeu terlipressina, ceftriaxona e, em 8 horas, ligadura elástica de varizes esofágicas com hemostasia. Está sonolenta, desorientada no tempo e com flapping (encefalopatia grau 2), com ascite volumosa e tensa. PA 104/62 mmHg, FC 98 bpm. Exames: bilirrubina 6,2 mg/dL, albumina 2,4 g/dL, INR 2,6, creatinina 1,3 mg/dL, sódio 129 mEq/L. Ecocardiograma com função ventricular normal e pressão sistólica pulmonar estimada

em 30 mmHg. O plantonista lembra que o TIPS preemptivo reduz mortalidade no Child C. A conduta mais adequada para a hipertensão portal neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

bilirrubina 6,2 mg/dL, albumina 2,4 g/dL, INR 2,6

Resolução. Child C com hemorragia varicosa é a situação em que o aluno aprendeu a indicar TIPS preemptivo, e o plantonista reforça essa ideia. A conta, porém, precisa ser feita: bilirrubina acima de 3 (3 pontos), albumina abaixo de 2,8 (3), INR acima de 2,3 (3), ascite volumosa (3) e encefalopatia grau 2 (2) somam 14 pontos. Os estudos que sustentam o TIPS preemptivo incluíram Child C de 10 a 13 pontos; com 14 ou 15 pontos a mortalidade continua proibitiva com ou sem TIPS, e a derivação ainda agrava a encefalopatia e pode precipitar insuficiência hepática. O Baveno VII restringe a indicação ao Child C abaixo de 14 pontos. Fica a terapia padrão: terlipressina por 2 a 5 dias, antibiótico e ligaduras seriadas, com discussão de prognóstico e de transplante.

A) Derivação portossistêmica cirúrgica
Errada. Derivação cirúrgica tem mortalidade proibitiva no Child C e foi abandonada no sangramento agudo.

B) Terlipressina por 5 dias e ligaduras seriadas CORRETA
Correta. Com 14 pontos o TIPS preemptivo não é indicado: vasoconstritor, antibiótico e ligaduras seriadas.

C) TIPS preemptivo com prótese recoberta ARMADILHA
Errada. É a armadilha do Child C: o benefício foi demonstrado entre 10 e 13 pontos, e esta paciente soma 14.

D) Obliteração retrógrada transvenosa por balão
Errada. A obliteração retrógrada se usa em varizes gástricas com shunt gastrorrenal, não em varizes esofágicas já ligadas.

Para levar. TIPS preemptivo tem faixa: Child C de 10 a 13 pontos (ou B acima de 7 com sangramento ativo). Com 14 ou 15 pontos ele é fútil e piora a encefalopatia.

de Franchis R et al. Baveno VII: Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022.

Revisa: S4 q33 e S3 q79: limites do TIPS, agora a faixa superior do Child-Pugh em que o preemptivo deixa de valer

---

42 Hematologia · Queda bifásica de plaquetas após revascularização com circulação extracorpórea: HIT pelo segundo vale, anticoagulante não heparínico sem esperar o anti-PF4

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 68 anos foi submetido a revascularização miocárdica com circulação extracorpórea e recebe enoxaparina profilática desde o primeiro dia pós-operatório. Plaquetas: 210.000/mm³ antes da cirurgia, 95.000/mm³ no segundo dia, 180.000/mm³ no quarto dia e 62.000/mm³ no sétimo dia. Sem sangramento, sem sinais de trombose ao exame e sem infecção identificada; não recebeu outros fármacos novos. Clearance de creatinina de 78 mL/min, função hepática normal. O ensaio anti-PF4 foi colhido e o resultado sai em 48 horas. A conduta mais adequada agora é:

O DADO QUE DECIDE

62.000/mm³ no sétimo dia

Resolução. A queda de plaquetas logo após circulação extracorpórea é esperada (hemodiluição e consumo no circuito) e se recupera em 3 a 4 dias; ela não pontua para HIT. O que importa é o segundo vale: plaquetas que voltaram ao normal e caem de novo mais de 50% entre o quinto e o décimo dia sob heparina, sem outra causa, dão escore 4T alto (6 pontos). Com probabilidade pré-teste alta não se espera o resultado: suspende-se toda heparina e inicia-se anticoagulante não heparínico em dose terapêutica, porque o risco de trombose na HIT isolada é de até 50%. Com função renal preservada, fondaparinux é opção adequada. Apenas suspender sem anticoagular deixa o paciente exposto à trombose, e varfarina na fase aguda provoca necrose e gangrena venosa.

A) Manter a enoxaparina e aguardar o anti-PF4
Errada. Manter heparina com escore 4T alto enquanto espera o teste expõe o paciente à trombose.

B) Fondaparinux em dose terapêutica CORRETA
Correta. Segundo vale de plaquetas entre o quinto e o décimo dia: 4T alto, suspender heparina e anticoagular com fondaparinux, com clearance preservado.

C) Varfarina com transfusão de plaquetas
Errada. Varfarina é contraindicada na fase aguda e plaquetas só se transfundem com sangramento ou procedimento de alto risco.

D) Suspender a heparina sem anticoagular ARMADILHA
Errada. É a armadilha do porte: HIT sem trombose aparente ainda exige anticoagulação terapêutica não heparínica.

Para levar. Após circulação extracorpórea, o primeiro vale de plaquetas é esperado; a queda de novo entre o quinto e o décimo dia é HIT, e com 4T alto anticoagula-se sem heparina antes do resultado.

ASH Guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia (Cuker A et al., Blood Adv 2018); Warkentin TE. Biphasic platelet count profile after cardiac surgery.

Revisa: S1 q97: HIT com escolha e porte do anticoagulante, agora pela cronologia bifásica da cirurgia cardíaca

---

43

Infectologia · Choque tóxico estafilocócico após tamponamento nasal com hemocultura negativa: oxacilina com clindamicina antitoxina

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 38 anos, previamente hígida, recebeu tamponamento nasal anterior com gaze há 4 dias por epistaxe, com orientação de retirada em 48 horas, que não ocorreu. Há 1 dia tem febre de 39,8 °C, vômitos, diarreia aquosa e mialgia intensa. Ao exame, PA 78 × 40 mmHg após 2 litros de cristaloide, FC 128 bpm, eritema difuso tipo queimadura solar em tronco e membros, hiperemia conjuntival e da mucosa oral. Creatinina 2,6 mg/dL, CK 4.200 U/L, plaquetas 82.000/mm³, bilirrubina total 2,4 mg/dL. Duas hemoculturas sem crescimento em 48 horas. O tampão foi retirado e o Gram da secreção mostra cocos Gram-positivos em cachos; a cultura identifica Staphylococcus aureus sensível à oxacilina e à clindamicina, com teste D negativo. Já está em noradrenalina. Além do suporte, o esquema antimicrobiano mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

cocos Gram-positivos em cachos

Resolução. Febre alta, eritrodermia, hipotensão refratária e disfunção de três ou mais órgãos com corpo estranho colonizado definem síndrome do choque tóxico; as hemoculturas negativas são esperadas na forma

estafilocócica, em que a doença é mediada pela toxina e não pela bacteremia. Como o agente é Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, a oxacilina basta para matar a bactéria, e é por isso que o esquema isolado atrai. O que falta nele é a inibição da síntese proteica, que reduz a produção da toxina (TSST-1) independentemente da fase de crescimento: a clindamicina (ou a linezolida) deve ser associada. A retirada do foco já foi feita, e a imunoglobulina intravenosa fica como adjuvante discutível nos casos refratários. Os cachos e a sensibilidade definida dispensam cobertura de amplo espectro e afastam o estreptococo, para o qual a penicilina seria o betalactâmico.

A) Oxacilina isolada ARMADILHA
Errada. É a armadilha: trata o estafilococo sensível, mas omite a droga antitoxina que muda o desfecho do choque tóxico.

B) Oxacilina com clindamicina CORRETA
Correta. Estafilococo sensível à oxacilina (cocos em cachos) com choque tóxico: betalactâmico antiestafilocócico mais clindamicina.

C) Vancomicina com meropenem
Errada. Seria empírico razoável antes da identificação, em choque sem foco definido; com sensibilidade conhecida, perde a ação antitoxina e amplia sem necessidade.

D) Penicilina cristalina com clindamicina
Errada. Seria o esquema do choque tóxico estreptocócico (cocos em cadeia); o Staphylococcus aureus produz penicilinase e não é coberto pela penicilina.

Para levar. No choque tóxico, estafilocócico ou estreptocócico, o betalactâmico certo para o agente vem sempre acompanhado de clindamicina para frear a toxina, e a hemocultura negativa não afasta a forma estafilocócica.

IDSA Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections (2014); CDC Toxic Shock Syndrome (Other Than Streptococcal) Case Definition 2011; Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022).

Revisa: S1 q88: no choque tóxico o betalactâmico isolado é insuficiente, falta a clindamicina antitoxina

---

44 Oncologia e paliativos · Ruído de secreção e edema nos últimos dias de vida sob hipodermóclise: suspender o soro e cuidar da boca

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 81 anos, com câncer de pâncreas metastático, está em cuidados de fim de vida no domicílio, acamada, dormindo a maior parte do dia e sem ingerir líquidos há 3 dias. A pedido da filha, que teme que a mãe 'morra de sede', a equipe iniciou há 2 dias hipodermóclise com 1.000 mL/dia de soro fisiológico. Hoje a filha está angustiada com um ruído borbulhante na garganta da mãe a cada respiração. A paciente está sonolenta, sem desconforto respiratório aparente, FR 22 irpm, com mucosa oral seca e crostas nos lábios, edema de membros inferiores 2+ e de mãos, e o ruído some parcialmente ao lateralizá-la. Usa morfina subcutânea em infusão contínua, com dor controlada. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

edema de membros inferiores 2+ e de mãos

Resolução. O ruído de secreções nos últimos dias de vida vem de secreções que a paciente não consegue deglutir, e a hidratação artificial aumenta seu volume, assim como o edema que já aparece em membros e

mãos. A furosemida parece resolver a sobrecarga sem abrir mão do soro, mas mantém a causa e acrescenta diurese num paciente acamado. Nos últimos dias, a sede e a boca seca não melhoram com volume parenteral: melhoram com cuidado oral frequente (umedecer a mucosa, hidratar os lábios). A conduta é suspender a hipodermóclise, reposicionar em decúbito lateral, cuidar da boca, considerar antimuscarínico e explicar à filha que o ruído não indica sofrimento nem afogamento. Aspiração frequente é desconfortável e estimula mais secreção.

A) Aspiração da orofaringe de 2/2 horas
Errada. Aspiração repetida é invasiva, desconfortável e pouco eficaz para secreções baixas; fica para secreção de orofaringe acessível.

B) Aumentar a hipodermóclise para 1.500 mL
Errada. Mais volume piora o ruído de secreção e o edema, e não alivia a sede no fim de vida.

C) Furosemida e manter a hipodermóclise ARMADILHA
Errada. É a armadilha: trata o edema mantendo a causa, a hidratação artificial que já não tem benefício.

D) Suspender o soro e fazer cuidado oral CORRETA
Correta. Sobrecarga com ruído de secreção nos últimos dias: retirar o soro e trocar por cuidado oral, com explicação à família.

Para levar. Nos últimos dias de vida, hidratação artificial não alivia a sede e aumenta secreção e edema: o cuidado oral substitui o soro.

NICE Guideline NG31: Care of dying adults in the last days of life (2015, atualizada 2017); Manual de Cuidados Paliativos da ANCP, 3ª ed. (2022).

Revisa: S4 q19: hidratação artificial nos últimos dias de vida, agora com o ruído de secreção e a furosemida como saída falsa

---

45 Reumatologia · Oligoartrite com uretrite recente, úlceras orais e genitais dolorosas e vasculite retiniana oclusiva: Behçet, e não artrite reativa

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 27 anos teve uretrite tratada com ceftriaxona e azitromicina há 5 semanas. Há 2 semanas tem dor e edema no joelho esquerdo e, há 4 dias, baixa visual no olho direito. Refere aftas orais dolorosas que voltam várias vezes por ano há 2 anos e, há 3 meses, uma úlcera escrotal dolorosa que deixou cicatriz. Ao exame, lesões papulopustulosas estéreis no tronco, artrite do joelho esquerdo, sem entesite, sem dactilite, sem lesões palmoplantares. Oftalmologia: uveíte posterior com vasculite retiniana oclusiva, sem conjuntivite. HLA-B27 negativo. Líquido sinovial inflamatório, sem cristais, cultura negativa. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

uveíte posterior com vasculite retiniana oclusiva

Resolução. Uretrite recente seguida de oligoartrite de joelho e acometimento ocular forma a tríade da artrite reativa, e a infecção é um antecedente verdadeiro. A artrite reativa, porém, dá conjuntivite ou uveíte anterior aguda, úlceras orais indolores e balanite circinada, e se associa ao HLA-B27. Aqui as aftas são dolorosas e recorrentes há anos, a úlcera escrotal é dolorosa e deixou cicatriz, há lesões papulopustulosas e, sobretudo, uveíte posterior com vasculite retiniana oclusiva, que é a lesão ocular da doença de Behçet e ameaça a visão. A artrite oligoarticular não erosiva de joelho também ocorre no Behçet. A uretrite foi coincidência ou gatilho de atividade. A uveíte posterior pede imunossupressão rápida (azatioprina ou anti-TNF, com glicocorticoide).

A) Artrite reativa ARMADILHA

Errada. É a armadilha da uretrite: a artrite reativa daria uveíte anterior ou conjuntivite e úlceras indolores, e não vasculite retiniana com úlcera genital cicatricial.

B) Sarcoidose

Errada. A sarcoidose dá uveíte e artrite de tornozelos, mas não úlceras orais e genitais dolorosas recorrentes.

C) Espondiloartrite da doença intestinal

Errada. A espondiloartrite da doença intestinal pede diarreia crônica e cursa com uveíte anterior; não há sintomas intestinais.

D) Doença de Behçet CORRETA

Correta. Aftas orais recorrentes, úlcera genital cicatricial, lesões papulopustulosas e vasculite retiniana oclusiva.

Para levar. Uveíte anterior com úlceras indolores e HLA-B27 é espondiloartrite ou artrite reativa; uveíte posterior com vasculite retiniana e úlceras orais e genitais dolorosas é Behçet.

Hatemi G et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet's syndrome; International Criteria for Behçet's Disease (ICBD, 2014).

Revisa: UERJ pouco explorado: Behçet contra artrite reativa, com a uretrite recente como rótulo verdadeiro

---

46 Endocrinologia · Insuficiência adrenal primária com candidíase mucocutânea desde a infância e hipoparatireoidismo: síndrome poliglandular tipo 1 (gene AIRE)

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 19 anos é internada por vômitos, hipotensão (PA 82 × 50 mmHg) e escurecimento da pele e das gengivas nos últimos meses. Sódio 126 mEq/L, potássio 6,1 mEq/L, glicemia 64 mg/dL, cortisol às 8 horas 1,9 µg/dL e ACTH 840 pg/mL. Anticorpo anti-21-hidroxilase positivo. Tem hipotireoidismo autoimune desde os 16 anos. Teve tetania aos 9 anos e usa calcitriol e carbonato de cálcio desde então. Refere candidíase oral e ungueal de repetição desde os 4 anos. Ao exame, hipoplasia do esmalte dentário e distrofia ungueal. A alteração de base mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

candidíase oral e ungueal de repetição desde os 4 anos

Resolução. Adrenalite autoimune com hipotireoidismo autoimune em mulher jovem é o perfil da síndrome poliglandular tipo 2, associada ao HLA-DR3 e DR4, e é o que se reconhece primeiro. O que muda o diagnóstico é a cronologia e os componentes: candidíase mucocutânea crônica desde os 4 anos, hipoparatireoidismo aos 9 anos e insuficiência adrenal na adolescência formam a tríade da síndrome poliglandular tipo 1 (APECED), com início na infância, herança autossômica recessiva e mutação no gene AIRE, que regula a tolerância central no timo. A displasia do esmalte e das unhas reforça. Na tipo 2 não há candidíase crônica nem hipoparatireoidismo, e o início costuma ser na vida adulta. A distinção importa para o rastreio dos irmãos e para vigiar hepatite autoimune, má absorção e falência ovariana.

A) Mutação no gene AIRE CORRETA

Correta. Candidíase mucocutânea na infância, hipoparatireoidismo e Addison definem a síndrome poliglandular tipo 1, por mutação no AIRE.

B) Mutação no gene FOXP3

Errada. A mutação no FOXP3 causa a síndrome IPEX, em meninos, com enteropatia grave e diabetes neonatal.

C) Haplótipo HLA-DR3 e DR4 ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o HLA-DR3/DR4 é da síndrome tipo 2 (Addison com tireoidite ou diabetes tipo 1), sem candidíase crônica nem hipoparatireoidismo.

D) Mutação no gene MEN1

Errada. A mutação no MEN1 causa hiperparatireoidismo, e não hipoparatireoidismo, com tumores hipofisários e pancreáticos.

Para levar. Candidíase mucocutânea crônica na infância, hipoparatireoidismo e Addison: síndrome poliglandular tipo 1, gene AIRE. Addison com tireoidite ou diabetes tipo 1 no adulto: tipo 2, HLA-DR3/DR4.

Husebye ES, Anderson MS, Kämpe O. Autoimmune Polyendocrine Syndromes. N Engl J Med 2018; Williams Textbook of Endocrinology, 14ª ed. (2020).

Revisa: S1 q25: síndrome poliglandular decidida pelo componente presente ou ausente; agora o que está presente leva ao tipo 1

---

47 Neurologia · Piora miastênica com queda da frequência cardíaca após colírio para glaucoma: betabloqueador tópico, e não crise colinérgica

Droga a deduzir **Gabarito D**

Mulher de 66 anos tem miastenia gravis generalizada com anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo, estável há 2 anos com piridostigmina 60 mg 4 vezes ao dia e prednisona 10 mg/dia, sem mudança de dose. Há 1 mês tratou cistite com nitrofurantoína, sem intercorrências. Há 10 dias o oftalmologista prescreveu um colírio para glaucoma de ângulo aberto, e desde então a frequência cardíaca, antes de 78 bpm, caiu para 54 bpm. Há 5 dias tem ptose bilateral, diplopia, voz anasalada e cansaço para mastigar. Pupilas de 4 mm, sem sialorreia, cólicas, diarreia ou fasciculações. CVF 2,1 L (2,4 L há 6 meses). TSH normal. TC de tórax de 1 ano atrás sem massa mediastinal. A causa mais provável da piora é:

O DADO QUE DECIDE

a frequência cardíaca, antes de 78 bpm, caiu para 54 bpm

Resolução. A droga não está nomeada: o colírio para glaucoma que derruba a frequência cardíaca é um betabloqueador tópico (timolol), absorvido pela mucosa nasal sem passar pelo fígado e com efeito sistêmico. Os betabloqueadores reduzem a eficiência da transmissão neuromuscular e estão entre as drogas que descompensam a miastenia, junto com aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, macrolídeos, magnésio e outras. A bradicardia atrai para crise colinérgica, mas a dose de piridostigmina não mudou, e faltam os sinais muscarínicos e nicotínicos do excesso (miose, sialorreia, cólicas, diarreia, fasciculações). Miopatia por corticoide é proximal, poupa a musculatura ocular e bulbar e não surge com dose estável de 10 mg. A conduta é trocar o colírio por análogo de prostaglandina e monitorar a CVF.

A) Crise colinérgica pela piridostigmina ARMADILHA

Errada. Exigiria aumento da dose ou sinais colinérgicos (miose, sialorreia, cólicas, fasciculações), ausentes; a bradicardia aqui tem outra causa.

B) Progressão por timoma

Errada. Timoma pode piorar a doença, mas não explica a coincidência com o colírio nem a queda da frequência cardíaca.

C) Miopatia pelo corticoide

Errada. Seria fraqueza proximal sem ptose nem diplopia, em dose alta e prolongada; a dose é baixa e estável.

D) Efeito do betabloqueador tópico CORRETA

Correta. O colírio que reduziu a frequência cardíaca é betabloqueador, droga que descompensa a miastenia.

Para levar. Na miastenia que piora sem mudança de dose, procure a droga nova, inclusive colírio: betabloqueador tópico tem efeito sistêmico, e a bradicardia que surge com ele é a pista.

Narayanaswami P et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 update. Neurology 2021; Sheikh S et al. Drugs that induce or cause deterioration of myasthenia gravis: an update. J Clin Med 2021.

Revisa: S3 q10: droga a deduzir que descompensa a miastenia (antes o magnésio, agora o colírio betabloqueador)

48

Cardiologia · Hipertrofia ventricular com túnel do carpo bilateral e ruptura de bíceps: amiloidose por transtirretina e baixa voltagem no ECG

Dado omitido **Gabarito B**

Homem de 79 anos, hipertenso há 25 anos com pressão bem controlada por losartana, tem dispneia progressiva aos esforços e edema de membros inferiores há 1 ano. Foi operado de síndrome do túnel do carpo nos dois punhos aos 68 e aos 70 anos, teve ruptura espontânea do tendão do bíceps direito e tem estenose de canal lombar. PA 112 × 70 mmHg, FC 64 bpm, jugulares túrgidas a 45 graus, hepatomegalia discreta. Ecocardiograma: septo e parede posterior de 17 mm, FE de 52%, padrão restritivo de enchimento e strain longitudinal com preservação apical. Imunofixação sérica e urinária negativas e relação de cadeias leves livres normal. O achado eletrocardiográfico que mais reforça a hipótese etiológica é:

O DADO QUE DECIDE

Foi operado de síndrome do túnel do carpo nos dois punhos

Resolução. Hipertensão de longa data é verdadeira e puxa para cardiopatia hipertensiva, cujo ECG mostra critérios de voltagem e padrão de strain. Mas a hipertrofia de 17 mm com pressão bem controlada e baixa, o túnel do carpo bilateral anos antes da insuficiência cardíaca, a ruptura do bíceps e a estenose lombar, a preservação apical do strain e o padrão restritivo compõem a amiloidose cardíaca, e as provas de cadeia leve normais apontam transtirretina (forma selvagem, do homem idoso). O infiltrado amiloide engrossa a parede sem gerar massa elétrica: a discordância entre parede espessa no eco e QRS de baixa voltagem é o achado que mais reforça a etiologia. A baixa voltagem não está sempre presente na forma por transtirretina, mas, quando aparece ao lado de hipertrofia, praticamente exclui hipertrofia verdadeira.

A) Bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional anterossuperior

Errada. É o ECG da cardiopatia chagásica, que dilata e afina, sem hipertrofia de 17 mm nem túnel do carpo.

B) Baixa voltagem dos QRS nas derivações periféricas CORRETA

Correta. Parede espessa com QRS de baixa voltagem é a discordância que denuncia infiltração amiloide.

C) Ondas T gigantes negativas de V2 a V5

Errada. Sugere cardiomiopatia hipertrófica apical, com espessamento da ponta, e não strain que preserva o ápice.

D) Critérios de Sokolow-Lyon com padrão de strain ARMADILHA

Errada. Seria o ECG da hipertrofia hipertensiva, que é miócito aumentado e gera voltagem alta; o rótulo da hipertensão é a isca.

Para levar. Hipertrofia no eco com voltagem baixa no ECG é infiltração até prova em contrário; túnel do carpo bilateral e ruptura do bíceps no idoso apontam amiloidose por transtirretina.

Diretriz da SBC sobre Diagnóstico e Tratamento da Amiloidose Cardíaca, 2021; 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies; Kittleson MM et al. 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Cardiac Amyloidosis.

Revisa: S2 q17 e S3 q5: da doença sistêmica ao achado esperado (aqui, ao ECG)

49

Nefrologia · Hipocalemia com alcalose e hipomagnesemia em jovem com suspeita de transtorno alimentar: cloro urinário alto e hipocalciúria, síndrome de Gitelman

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 24 anos, estudante de nutrição, IMC de 19 kg/m², é encaminhada pela psiquiatra com suspeita de bulimia por cãibras, fadiga e episódios de parestesias em mãos; a dentista notou desgaste do esmalte. Ela nega vômitos, laxantes e diuréticos. PA 104/66 mmHg, sem edema. Potássio 2,8 mEq/L, bicarbonato 32 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL (1,7 a 2,4), cálcio 9,8 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL. Urina: cloro 92 mEq/L, potássio 64 mEq/L, relação cálcio/creatinina de 0,03 mg/mg; pesquisa urinária de diuréticos negativa em duas amostras colhidas sem aviso. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

cloro 92 mEq/L

Resolução. A suspeita de bulimia, o desgaste dentário e a profissão são verdadeiros e puxam para vômitos autoinduzidos, a causa mais comum de hipocalemia com alcalose em mulher jovem. O cloro urinário separa: nos vômitos o rim retém cloro (abaixo de 20 a 25 mEq/L), e aqui ele está alto, indicando perda renal de sal. Entre as causas renais, a pesquisa de diuréticos negativa repetida afasta o uso oculto, e a hipocalciúria com hipomagnesemia aponta defeito no cotransportador sódio-cloro do túbulo distal, que imita o tiazídico. Bartter e o diurético de alça produzem hipercalciúria. O diagnóstico é síndrome de Gitelman.

A) Síndrome de Bartter

Errada. Bartter afeta a alça de Henle, como a furosemida, e cursa com cálcio urinário normal ou alto.

B) Uso oculto de diurético de alça

Errada. A alça também daria hipercalciúria, e a pesquisa de diuréticos foi negativa duas vezes.

C) Síndrome de Gitelman CORRETA

Correta. Alcalose hipocalêmica com cloro urinário alto, hipocalciúria e hipomagnesemia, sem diurético: Gitelman.

D) Vômitos autoinduzidos ARMADILHA

Errada. É a armadilha do rótulo: nos vômitos o cloro urinário é baixo, e aqui é 92 mEq/L.

Para levar. Alcalose hipocalêmica normotensa: cloro urinário baixo é vômito; cloro alto com cálcio urinário baixo e magnésio baixo é Gitelman (ou tiazídico); com cálcio urinário alto, Bartter ou alça.

Blanchard A et al. Gitelman syndrome: consensus and guidance from a KDIGO Controversies Conference. Kidney Int 2017.

Revisa: UERJ pouco explorado: tubulopatias, Gitelman contra o rótulo de transtorno alimentar pelo cloro e cálcio urinários

---

50 Pneumologia · TEP de risco intermediário-alto que descompensa sob heparina: reclassificar como alto risco e trombolisar

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 63 anos, no 4º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, teve TEP confirmado por angiotomografia há 10 horas, com trombos nas duas artérias pulmonares principais. Na admissão estava com PA 118 × 74 mmHg, FC 112 bpm, VD/VE de 1,3 ao ecocardiograma e troponina elevada, e iniciou heparina não fracionada em infusão, com TTPa no alvo. Agora está sudoreico, confuso, com PA sistólica de 82 mmHg por 20 minutos apesar de 500 mL de cristaloide, FC 128 bpm, lactato 4,6 mmol/L, SpO2 88% com cateter de oxigênio. Não teve sangramento da ferida, hemoglobina estável, plaquetas 210.000/mm³, sem AVC prévio. Classificação de risco atual e conduta, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PA sistólica de 82 mmHg por 20 minutos

Resolução. Na admissão, disfunção de ventrículo direito com troponina alta e pressão normal classificava o TEP como intermediário-alto, e a conduta certa era anticoagular e vigiar, o que faz manter a heparina parecer coerente agora. A classificação, porém, é dinâmica: pressão sistólica abaixo de 90 mmHg por mais de 15 minutos com hipoperfusão (confusão, lactato alto) é instabilidade hemodinâmica, e o TEP passa a ser de alto risco. A descompensação sob anticoagulação é exatamente a indicação de trombólise de resgate. A cirurgia de 4 dias é contraindicação relativa, e não absoluta, e o risco de morrer de choque obstrutivo supera o de sangrar; se houver contraindicação absoluta ou falha, a alternativa é embolectomia cirúrgica ou terapia por cateter. Filtro de veia cava não trata o trombo que já está no pulmão.

A) Alto / trombólise sistêmica CORRETA

Correta. Hipotensão sustentada com hipoperfusão sob heparina: alto risco e trombólise sistêmica de resgate.

B) Intermediário-alto / manter heparina e vigiar ARMADILHA

Errada. É a armadilha: era a conduta na admissão, mas a hipotensão sustentada com hipoperfusão reclassifica o caso como alto risco.

C) Alto / filtro de veia cava inferior

Errada. O filtro é para quem não pode ser anticoagulado; não alivia a obstrução que está causando o choque.

D) Intermediário-alto / trombólise em meia dose

Errada. Mantém a classificação antiga, e a meia dose não é o padrão do TEP com choque.

Para levar. O risco do TEP é reavaliado a cada momento: o intermediário-alto que fica hipotenso sob anticoagulação vira alto risco e recebe trombólise de resgate.

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism; Recomendações da SBPT para TEP (2010).

Revisa: S2 q52: grade de risco do TEP (intermediário-alto x alto) define trombólise; aqui vista pela reclassificação